BIEN-ETRE DES PERSONNES AGEES :

ETUDE COMPARATIVE ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA SUEDE

Rédigé par : HABONIMANA kétia

Table des matières

Avant-propos 4

I. Introduction 4

I. Santé physique 8

- Etat de santé perçu par pays 9
- Etat de santé perçu selon le genre : 9
- Etat de santé perçu selon l'âge : Excellente VS médiocre 10
- Les maladies chroniques 11
- L'indice de masse corporelle 12
- La consommation du tabac : 13
- Fréquence d'activité physique 14

II. Santé mentale 15

- Euro-D 16
- Sentiments de tristesse 17
- Envie suicidaire 18
- CASP : qualité de vie et de bien être 19
- Capacité de mémorisation 20
- Test de mathématique 21
- Orientation dans le temps 21

III. Dépendance 22

- Indice des activités de la vie quotidienne 23
- Indice des activités instrumentales 24
- Indice de mobilité 25
- Indice de force musculaire 27
- Vivre avec son partenaire sous le même toit que le répondant 28
- Au moins un enfant vit dans la même maison que le répondant 29
- Proximité géographique avec le(s) enfant (s) 29
- Aide reçue de l'extérieure du ménage 30
- Les cinq premières personnes offrant leur aide aux répondants 30

IV. Accès aux soins 31

- Hospitalisations lors des 12 derniers mois par pays et selon l'âge 32
- Les nuitées en maison de retraite au cours des 12 derniers mois 33

V. Dépenses de santé 34

- Dépenses publiques de santé dans le Produit Intérieur Brut (PIB) 34
- Part du budget national 36

- Dépenses de santé par habitant 37

VI. Conclusion 38

VII. Bibliographie 40

Avant-propos

Ce projet sur la vieillesse et la santé vise à comprendre et comparer la situation des personnes âgées en Allemagne et en suède. En nous basant sur les données de la neuvième vague de l'enquête Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) et les statistiques nationales comme celles de la banque mondiale, nous analyserons l'état de santé physique et mental, la dépendance, l'accès aux soins et les dépenses de santé pour comprendre comment ces deux pays répondent aux défis contemporains du vieillissement de la population et identifier sur quels leviers les politiques publiques peuvent agir pour favoriser, aux personnes âgées, une inclusion totale dans la société et ainsi mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

I. Introduction

Depuis plusieurs décennies, le monde et l'économie font face à une pression énorme à cause du vieillissement démographique. Les systèmes de santé se retrouvent avec davantage de personnes âgées à soigner, dont les besoins sont souvent complexes et les ressources financières très rares.

Alors que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter dans les pays développés, les taux de fécondité continuent de diminuer[1], modifiant toute la structure de la société. Conséquence, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses que les jeunes, susceptibles de leur apporter confort et soutien tant financier que moral.

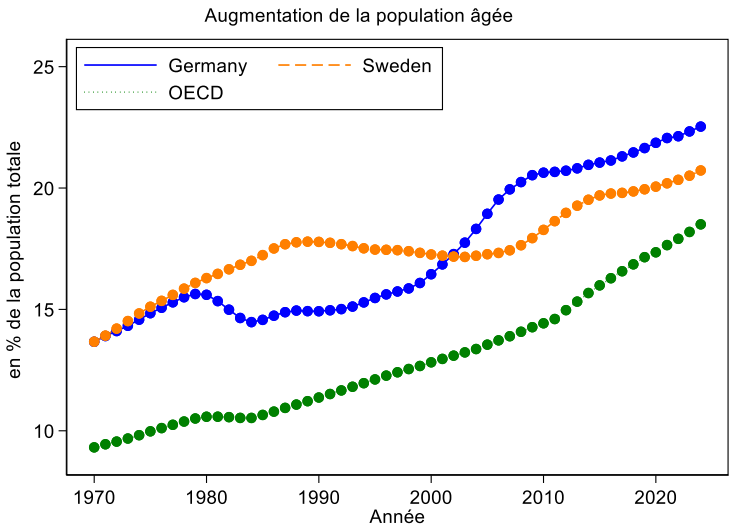
Si les progrès médicaux permettent de vivre plus longtemps, ils posent donc d'importants défis quant à la qualité de vie des années supplémentaires et à la soutenabilité des systèmes de soins de santé qui leur promettent une bonne qualité de vie après leur carrière.

Selon l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)[2], en France, les personnes âgées d'au moins 65 ans représentaient, en 2020, 20,5% de la population, augmentant de 4,7 points de pourcentage, si on regarde 20 ans en arrière. Ce qui représente un chiffre énorme qui ouvre la porte à plusieurs débats.

[1] Koutsogeorgopoulou, V. et H. Morgavi (2025), « Vieillissement des populations, ses implications fiscales et les réponses politiques », Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE , n° 1844, Éditions OCDE, Paris.

[2] Population par âge – Tableaux de l'économie française | Insee

De plus, cette augmentation du pourcentage des personnes âgées se reflète dans la majorité des pays de l'Union Européenne (UE), voire partout dans le monde. Et l'Allemagne et la Suède ne sont pas, du tout, épargnées.



Nous pouvons le constater, à travers ce graphique de l'OCDE, que malgré certaines fluctuations, sur le long des courbes, le pourcentage de la population des personnes âgées de 65 ans ou plus continue de progresser et de constituer une part importante de la population totale. Nous notons également que c'est la proportion allemande des 65 ans ou plus qui est la plus grande par rapport à celles des suédois d'au moins 65 ans et tous les deux dépassent la moyenne des pays de l'OCDE.

Cependant, cette transition démographique ne se limite pas à un simple allongement de la vie mais cache des différences significatives en matière d'état de santé des personnes âgées et des politiques publiques déployées par chaque pays pour y faire face.

En effet, la vieillesse s'accompagne, souvent, d'une augmentation des maladies chroniques, des incapacités, des situations de dépendance, des besoins en soins de santé, de sentiments de solitude, etc, nécessitant des soins et accroissant, de ce fait, les dépenses en santé. Dans ce contexte, l'espérance de vie en bonne santé devient un indicateur tout aussi important que l'espérance de vie globale.

D'après Cambois Emmanuelle et al. (2004), la part des personnes déclarant des incapacités augmente très fortement avec l'âge, passant de plus 45% chez les 60-64 ans à jusqu'à 88% chez les 80-84 ans[3].

[3] Cambois, Emmanuelle., et al. « Femmes et hommes ne sont pas égaux face au handicap ». Gérontologie et société, 2004/3 vol. 27 / n° 110, 2004. p.283-291.

Les personnes âgées sont ainsi souvent confrontées à plusieurs types de difficultés liées à leur santé en même temps.

Premièrement, nous pouvons évoquer la première dimension qui est la santé physique. Selon Lepori Mélanie (2017), celle-ci ne doit pas être décrite seulement comme un déclin biologique inévitable, mais aussi la manière dont les personnes âgées perçoivent elles-mêmes leur propre vulnérabilité. Cette perception, que nous évaluons souvent en regardant les capacités de mobilité, à prendre soin de soi ou à accomplir les activités quotidiennes, à dépendre aux autres, reste généralement faible chez les plus de 60 ans vivant chez eux. Toutefois, tout le monde ne vit pas cela de la même manière. Par exemple, les femmes, les personnes ayant un âge très avancé, surtout après 80 ans, et celles dont les ressources financières sont moindres font face à une vulnérabilité physique plus accrue.

Ensuite, la santé mentale représente une autre dimension de la vieillesse. Comme le souligne Meynet Stéphanie et al. (2022)[4], la santé mentale ne se résume pas simplement à l'absence des troubles mentaux, mais il s'agit plus largement d'un état de bien-être, qui peut être fragilisé par différents facteurs, tels que l'exclusion sociale, la perte de proches, les incapacités physiques ou encore la diminution de l'autonomie. Ici, nous voyons plusieurs éléments qui peuvent, sur le long terme, favoriser l'apparition de signes de dépression, d'anxiété ou d'un sentiment de solitude chez les personnes âgées.

Enfin, viennent l'accès aux soins de santé et les dépenses de santé. Les personnes âgées sont en quête de soins de santé à cause de la vieillesse. Et souvent, elles habitent dans les milieux ruraux qui sont réputés pour être des déserts médicaux. D'après Catherine Gucher (2013), en 2006, la population française comptait 27,5% de plus de 60 ans et 11,4% de plus de 75ans en zone rurale, contre respectivement 20% et 7,7% dans l'espace urbain, des chiffres qui, à notre avis, ont dû augmenter proportionnellement au vieillissement. Or, comme le montre l'auteur Jean-Claude Bontron (2013)[5], ces zones rurales sont également celles où l'accès aux soins de santé est le plus précaire. Nous y observons une pénurie des professionnels de santé, des difficultés importantes à se déplacer à cause des longs trajets, des offres de services de santé qui se raréfient, et ainsi de suite. Pour les personnes âgées, cela les contraint à recourir tardivement à des soins, voire à renoncer à certains suivis médicaux, ce qui accentue les inégalités territoriales d'accès aux soins.

Parallèlement, ces difficultés d'accès aux soins de santé peuvent alourdir les dépenses de santé à charge des personnes âgées. C'est un enjeu également financier, car il est lié fortement aux systèmes de retraite

[4] Meynet, Stéphanie., et al. « Promouvoir la santé mentale des personnes âgées avec des incapacités physiques : revue systématique des interventions proposées à domicile et en établissement ». Recherche en soins infirmiers, 2022/4 N° 151, 2022. p.18-29.

[5] Bontron, Jean-Claude. « L'accès aux soins des personnes âgées en milieu rural : problématiques et expériences ». Gérontologie et société, 2013/3 vol. 36 / n° 146, 2013. p.153-171.

des pays. En Allemagne, où le montant de la pension dépend des cotisations versées au cours de la vie active, les personnes ayant perçus des revenus modestes disposent souvent peu de ressources, rendant le reste à charge des soins plus difficile à payer.
En Suède, le système de retraites cherche davantage à lisser les inégalités grâce à un minimum garanti pour les revenus les plus modestes et à la petite part du revenu qui est consacrée à la capitalisation obligatoire, mais cela laisse une grande partie de la capacité à assumer les frais de santé au niveau des revenus. Ce qui contribue à perpétuer, et parfois même à aggraver, les inégalités face à la perspective de vieillir en bonne santé.

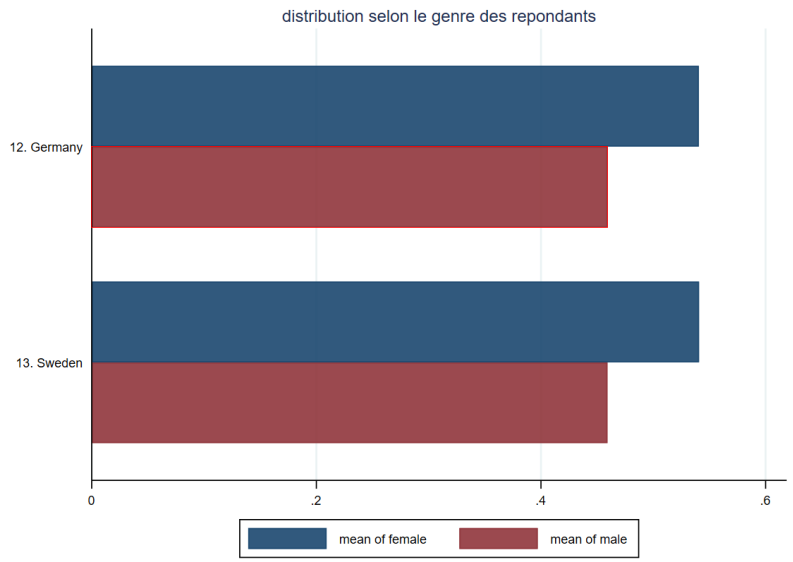
Face à tous ces éléments, nous effectuerons une analyse comparative entre l'Allemagne et la Suède, à travers des analyses exploratoires et descriptives, afin d'examiner les différentes dimensions de la santé des personnes âgées et éventuellement, identifier des pistes d'actions qui pourraient être bénéfiques pour les politiques publiques futures.

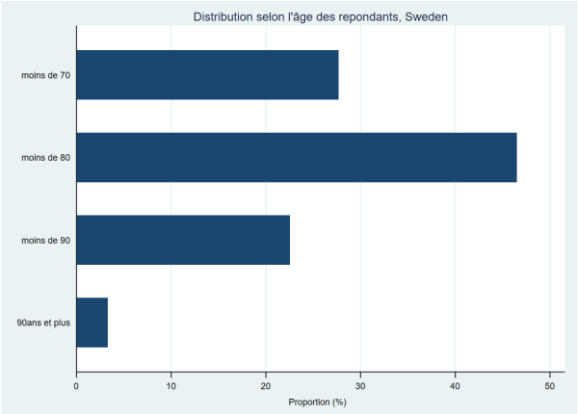
Pour notre étude, nous avons choisi de composer notre échantillon de personnes âgées de 60 ans ou plus, car c'est souvent la limite d'âge dont les politiques de vieillesse prend en considération en France[6].

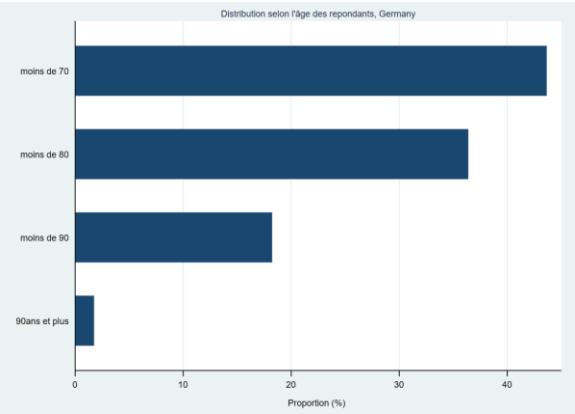
II. Analyse comparative entre l'Allemagne et la Suède

Notre échantillon est composé majoritairement de femmes que d'hommes. Que ça soit en Allemagne ou en Suède, les femmes restent la proportion la plus élevée des répondants. C'est une base de données qui s'est constitué sur deux ans, en 2021 et 2022. En Allemagne, on compte en total 4 467 répondants contre 2 428 en Suède, ce qui fait un total de 6 895 individus.

[6] Mélanie Lepori, « La vulnérabilité physique perçue par les personnes âgées, une comparaison européenne », Populations vulnérables, 3 | 2017, 97-133.







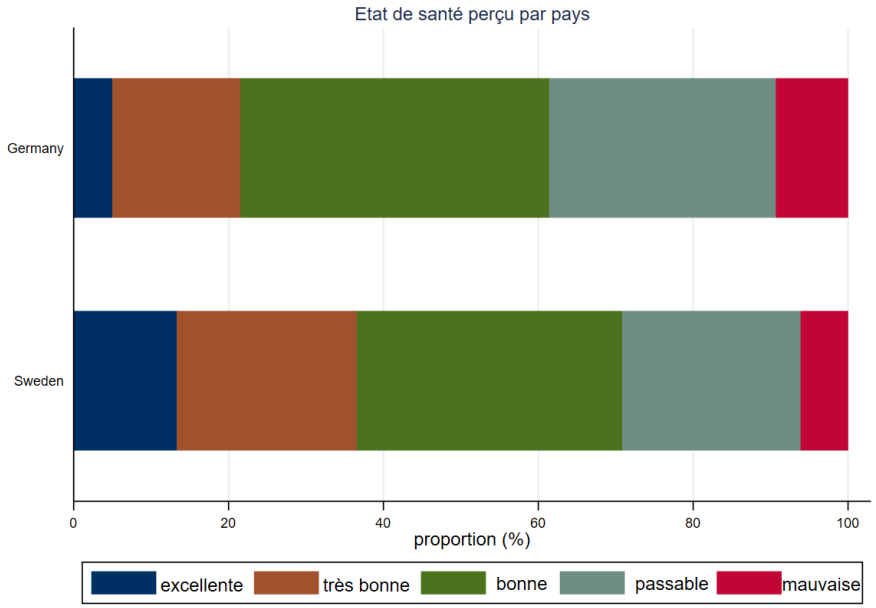
Concernant la distribution selon l'âge, en Suède, la majorité des répondants sont de moins de 80 ans, suivis par ceux ayant un âge compris entre 60 et 70 ans. En Allemagne, c'est le contraire. Ce sont les répondants qui se situent dans la classe de 60 – 70 ans, et les âgés d'entre 70 et 80 ans suivent. Dans les deux pays, les individus âgés de 90 ans ou plus sont les moins représentés, avec une part légèrement plus élevée en Suède.

I. Santé physique

Pour analyser la santé physique des personnes âgées, les répondants ont répondu à des questions concernant leur perception de leur état de santé. Nous présenterons d'abord l'état de santé perçu par pays, puis sa distribution selon le genre et selon l'âge. Nous comparerons également la santé physique entre l'Allemagne et la Suède en nous appuyant sur le nombre de maladies chroniques que présentent leurs citoyens respectifs, l'indice de masse corporel, la consommation de tabac et la fréquence des activités physiques.

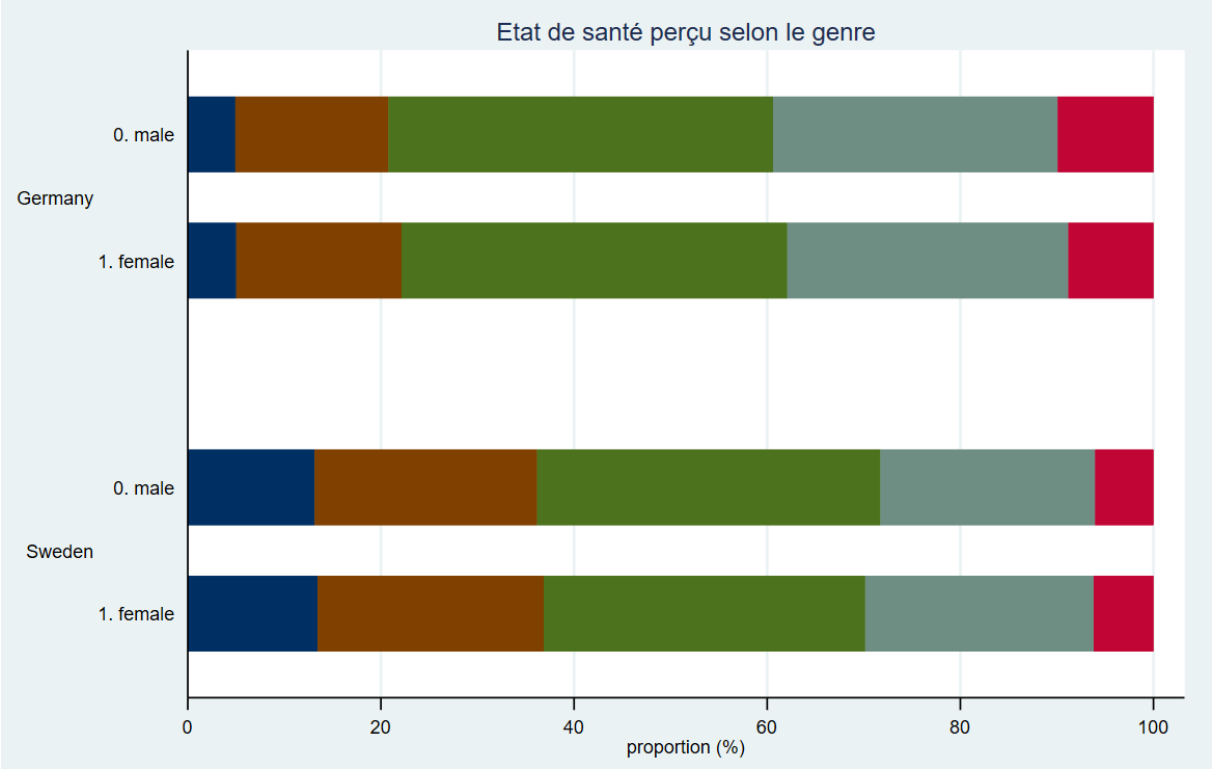
Etat de santé perçu par pays

L'état de santé est subjectif. Il va être évalué en fonction de la perception qu'à chaque personne se sent de son bien-être et de ses capacités fonctionnelles de manière générale. Bien qu'elle ne soit pas la mesure la plus fiable pour déterminer la santé physique d'un pays, elle permet de comprendre comment la santé est réellement ressentie au sein d'un pays, d'un groupe d'âge, etc.



D'après ce graphique, il y a plus de Suédois qui perçoivent leur état de santé comme étant excellent par rapport aux Allemands. A l'inverse, moins de Suédois déclarent avoir un état de santé médiocre que d'Allemands. Et cela se traduit dans l'ensemble des catégories. Pour les états de santé perçus comme très bons, la Suède l'emporte mais pour les états considérés comme les mauvais, c'est l'Allemagne qui est majoritaire.

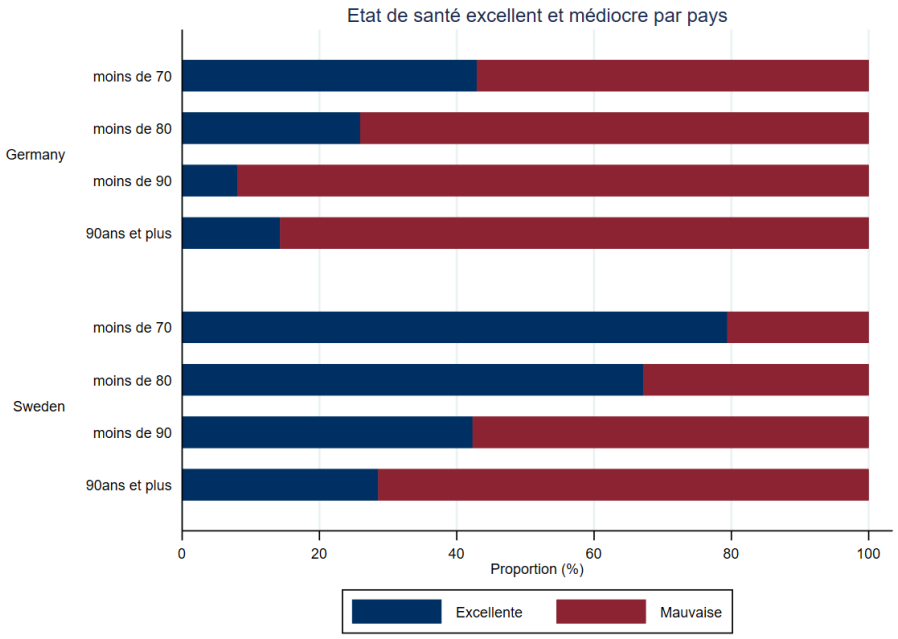
Etat de santé perçu selon le genre :



La distribution selon le genre ne nous renseigne pas grand-chose, si ce n'est que confirmer que, même dans le genre, les suédois sont ceux qui affichent un meilleur état de santé. Les femmes suédoises et les hommes suédois ressentent un état de santé nettement supérieur à celui des femmes allemandes et des hommes allemands. Et toujours, ce sont les Allemands qui affichent un état de santé médiocre bien supérieur à celui des Suédois.

- Etat de santé perçu selon l'âge : Excellente VS médiocre

Ici, nous avons comparé uniquement l'état de santé perçu comme le meilleur et celui perçu comme le plus médiocre afin de voir les catégories d'âge se sentent le plus en mauvais état de santé et celles qui le ressentent le moins.

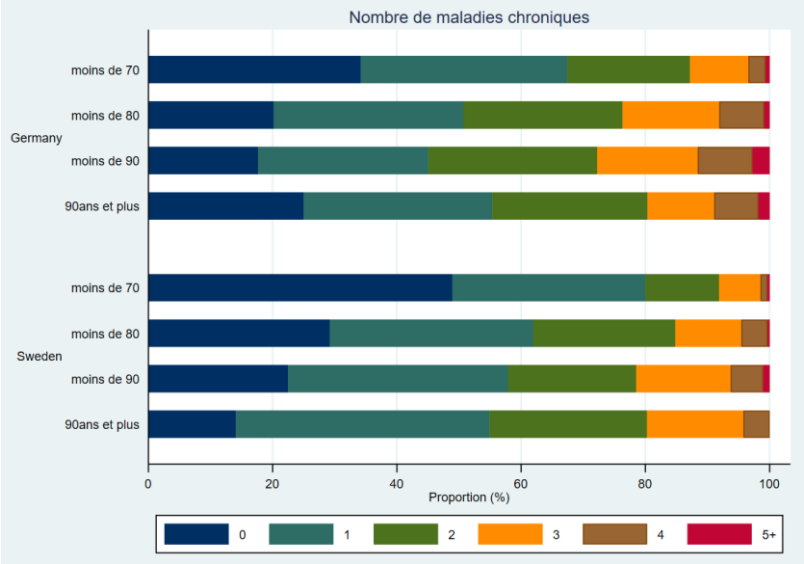


Dans toutes les catégories d'âge, les Suédois sont toujours en premier en ce qui concerne l'état de santé perçu comme excellent. La tranche d'âge avec se sentent plus en forme est celle des moins de 70 ans, donc avec un âge situé entre 60 et 70 ans, nous voyons que la perception de l'état de santé varie avec l'âge. Elle diminue au fur et à mesure qu'on avance en âge, à l'exception des Allemands de moins de 90 ans qui ressentent l'état excellent le plus bas que les plus de 90ans. Cela illustre bien la nature subjective de cette mesure.

Donc, pour les Allemands, ce sont les personnes âgées entre 80 et 90 ans qui ressentent le plus médiocre des états de santé et pour les Suédois, ce sont les plus de 90 ans.

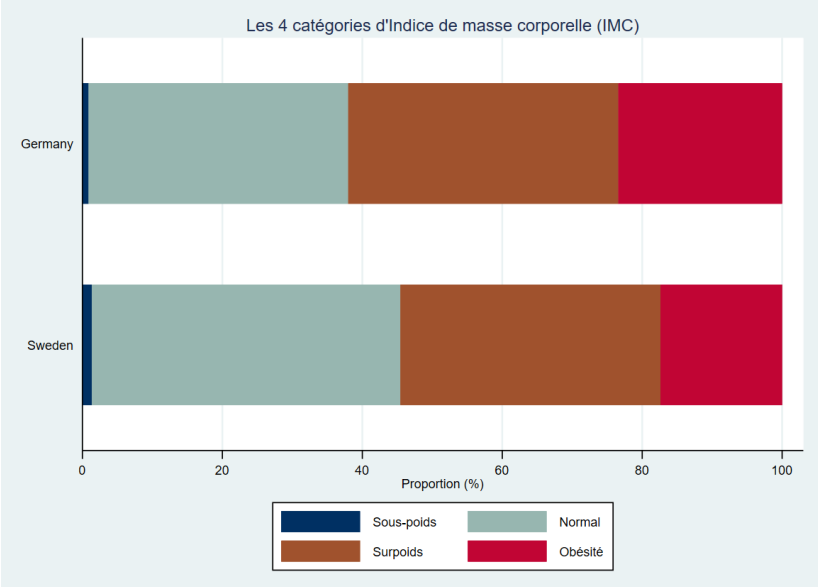
Les maladies chroniques

Elles concernent uniquement les maladies diagnostiquées par les médecins. Il s'agit notamment des cancers, diabète, maladie de Parkinson, AVC, les maladies pulmonaires, etc.



Dans les deux pays, les moins de 70 ans sont ceux qui présentent le plus aucune maladie chronique. La Suède montre clairement le fait que les plus âgés sont les plus vulnérables à voir leur nombre de maladies chroniques augmentait. Par contre, en Allemagne, les individus âgés de 90 ans et plus sont plus nombreux à ne déclarer aucune maladie chronique que ceux âgés entre 70 et 80 ans. Enfin, la catégorie entre 80 et 90 ans est celle avec une proportion plus élevée d'individus déclarant 5 maladies chroniques ou plus, dans les deux pays.

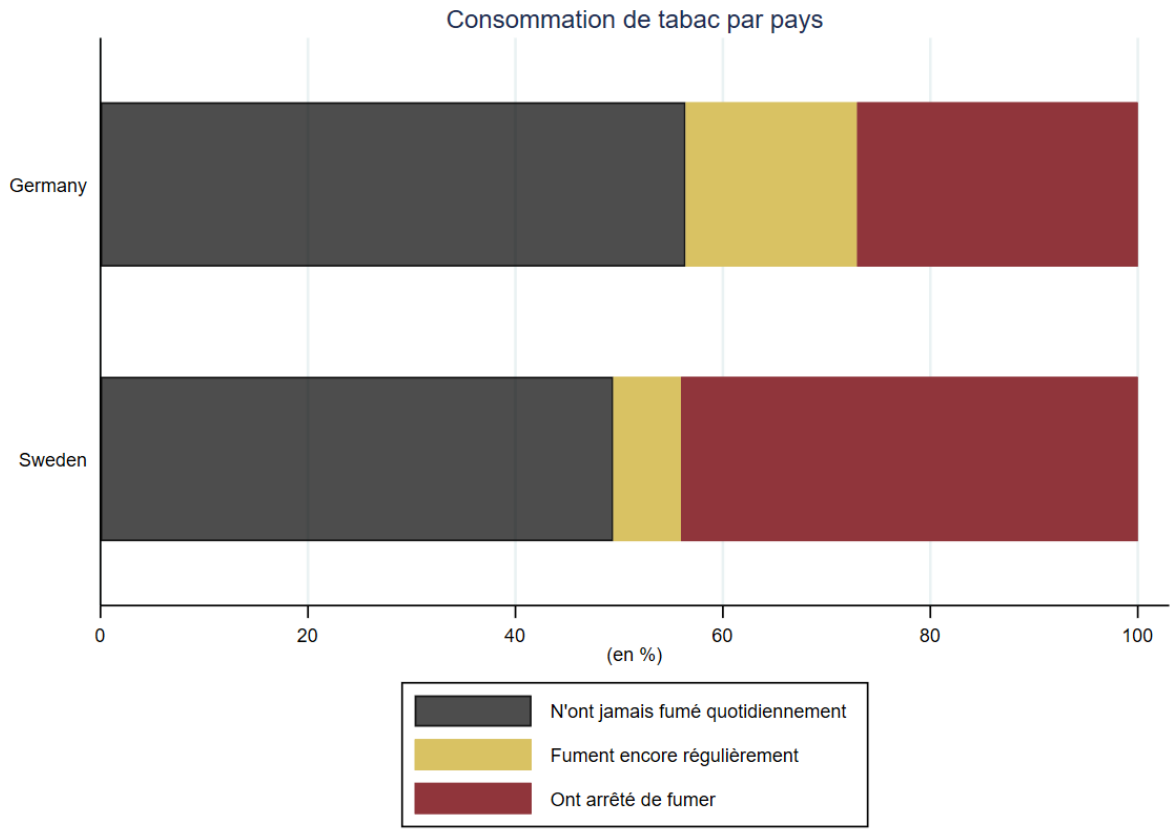
L'indice de masse corporelle



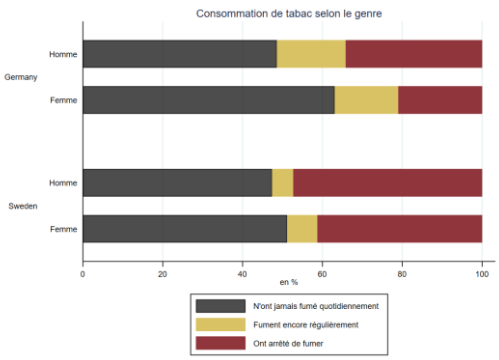
Une faible part d'individus a déclaré être en situation de sous-poids dans les deux pays, bien que cette proportion soit légèrement plus élevée pour les suédois. Les répondants avec un poids idéal sont

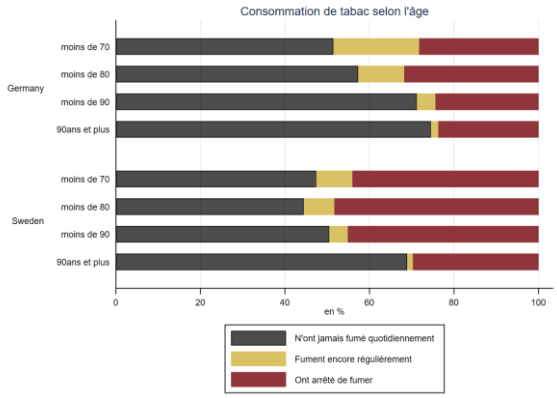
majoritairement suédois et ceux en situation d'obésité sont plus nombreux en Allemagne. Néanmoins, dans les deux pays, la majorité des individus se répartit entre le poids idéal et le surpoids, avec des proportions presque égales.

- La consommation du tabac :



La consommation régulière du tabac est plus concentrée chez les Allemands. La proportion qui a arrêté de fumer est plus grande chez les Suédois. La part des individus qui n'ont jamais fumé quotidiennement est plus forte en Allemagne qu'en Suède. Les allemands semblent être les plus consommateurs du tabac par rapport aux Suédois. Cependant, afin d'approfondir ce constat, il est intéressant d'examiner de près la distribution de la consommation de tabac selon l'âge et le genre pour entrer plus en détail

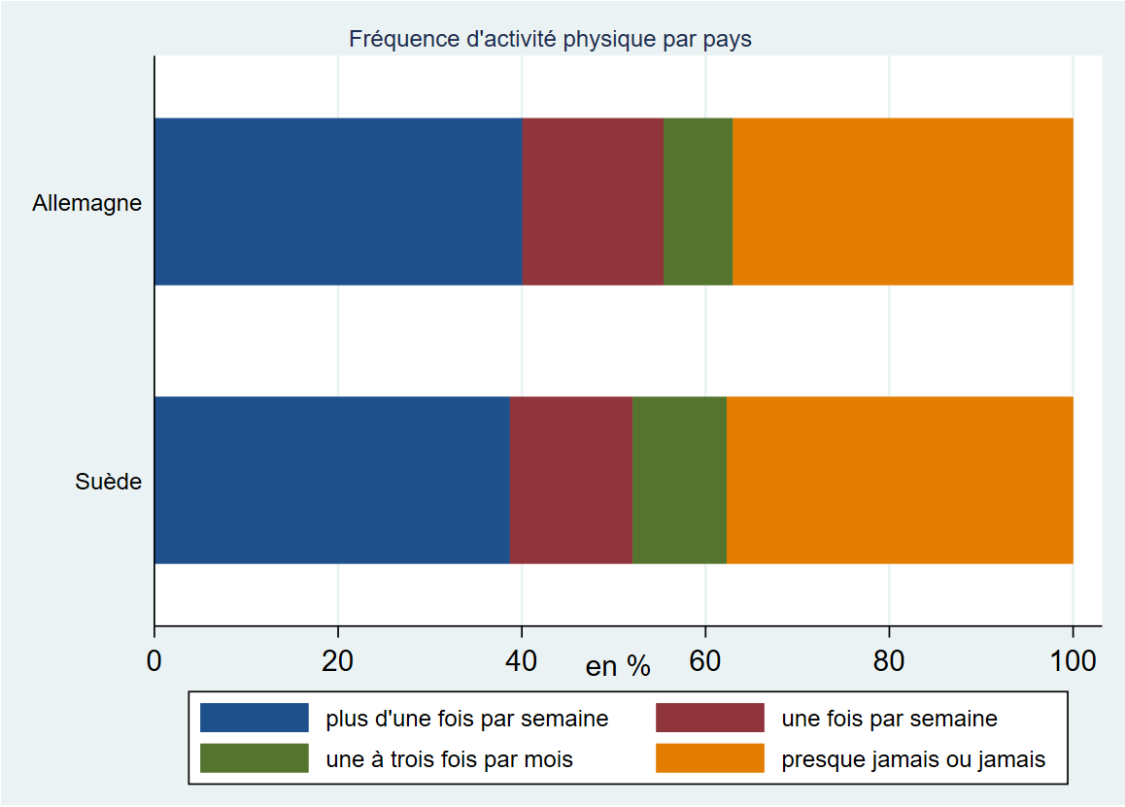




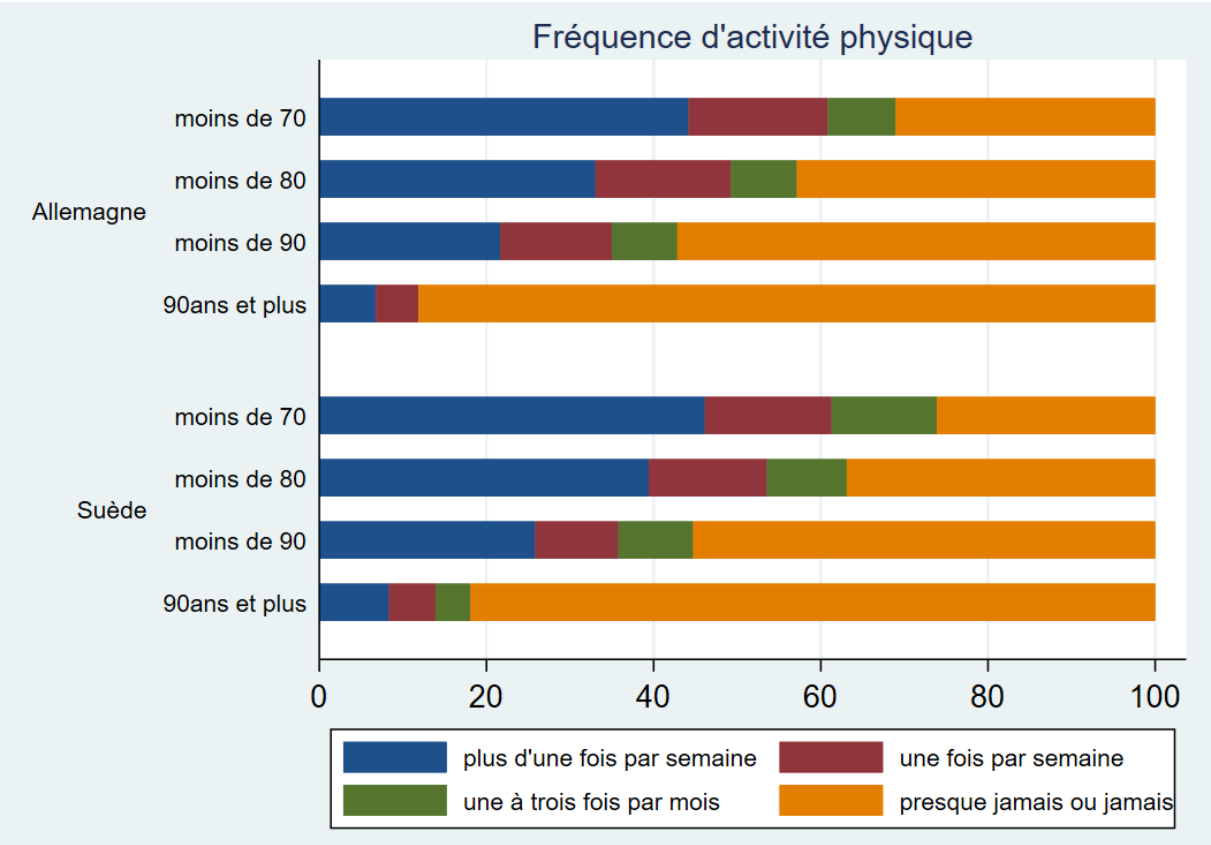
Nous remarquons que les femmes allemandes n'ont pas fumé quotidiennement par rapport aux femmes suédoises. En revanche, dans cette catégorie, la proportion est la même pour les hommes. Actuellement, les hommes allemands et les femmes allemandes fument encore régulièrement que les hommes et les femmes suédois. Les personnes âgées entre 60 et 80 ans sont celles qui fument le plus encore actuellement et de façon régulière que les autres classes d'âge, mais les Allemands restent les plus nombreux. La proportion de ceux qui ont arrêté de fumer sont toujours majoritairement les suédois.

Fréquence d'activité physique

Intéressons-nous maintenant aux comportements liés aux activités sportives dans les deux pays.



Les deux pays semblent avoir les mêmes fréquences d'activités physiques. Une répartition équitable reste notable entre les deux extrêmes, avec d'un côté, plusieurs fois par semaine et le presque jamais ou jamais. Cela montre une attention particulière à l'incitation des personnes âgées aux exercices physiques.



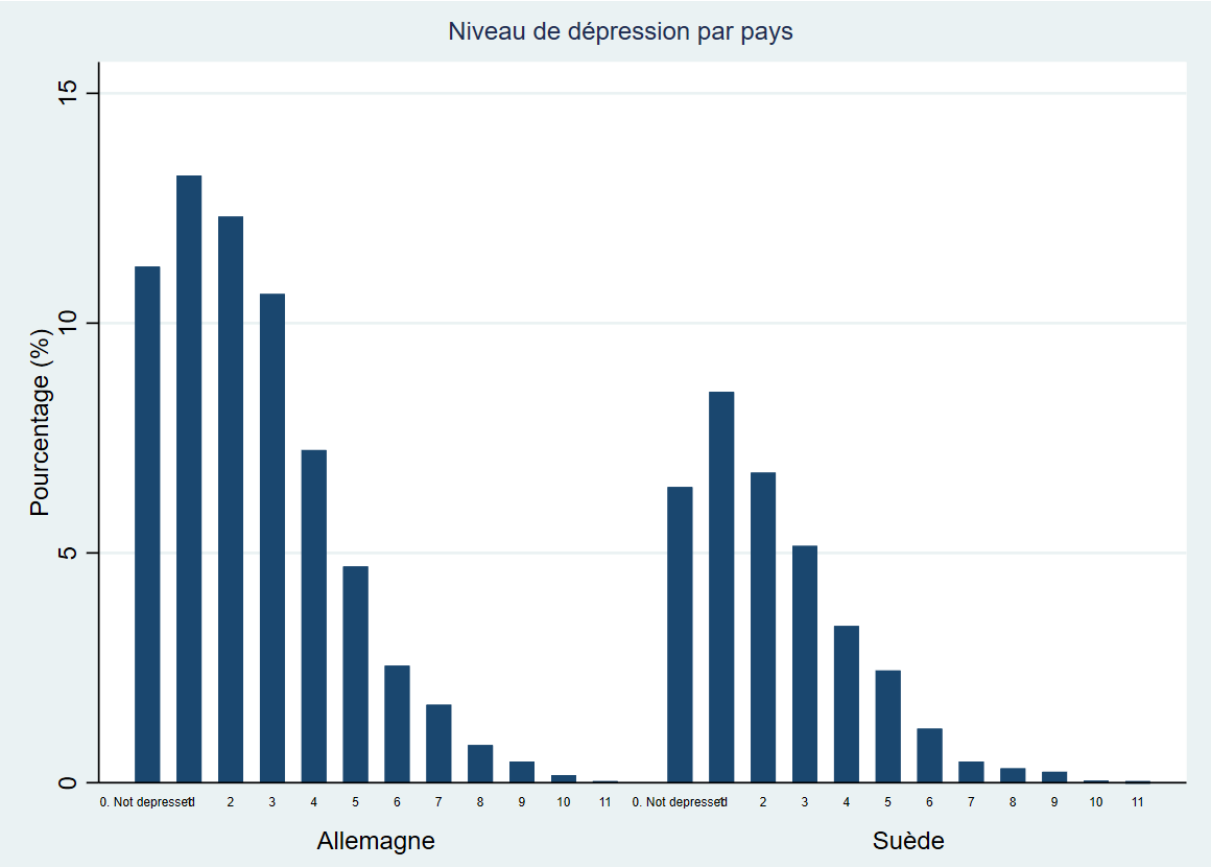
Nous pouvons le voir, sur cette distribution selon l'âge, les proportions entre les âges semblables sont presque les mêmes, dans les deux pays, même si la suède semble avoir un léger avantage sur l'Allemagne. L'activité physique aussi varie selon l'âge. L'âge a l'air d'inciter les individus à ne plus s'exercer. Les plus sportifs (plus d'une fois par semaine) sont les moins de 70 ans, avec une proportion d'environ 42% provenant de la catégorie 60-70 ans, et les moins restent les plus de 90 ans, avec environ 10% de participation aux activités sportives dans cette catégorie d'âge.

II. Santé mentale

A présent, nous allons analyser les différents indicateurs de la santé mentale dans l'objectif d'examiner comment ces dimensions de la santé mentale se manifestent et varient chez les personnes âgées.

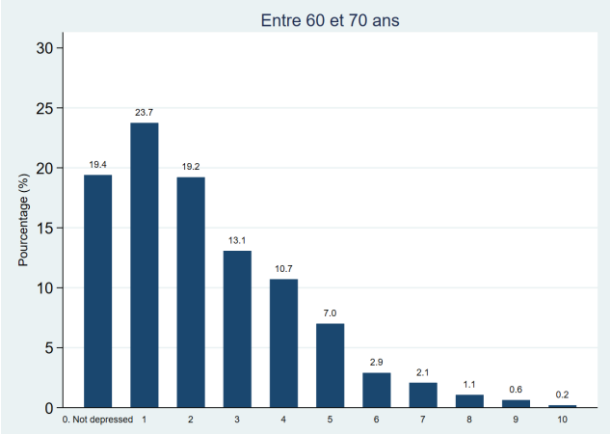
- Euro-D

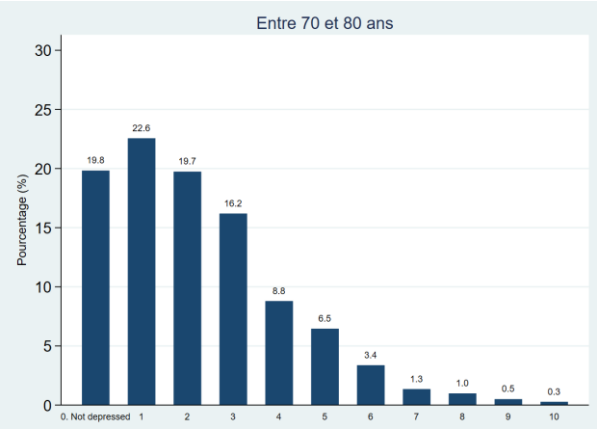
Cet indicateur permet de mesurer les symptômes dépressifs en cours. Il varie de 0, absence de dépression, à 12, niveau élevé de symptômes dépressifs.

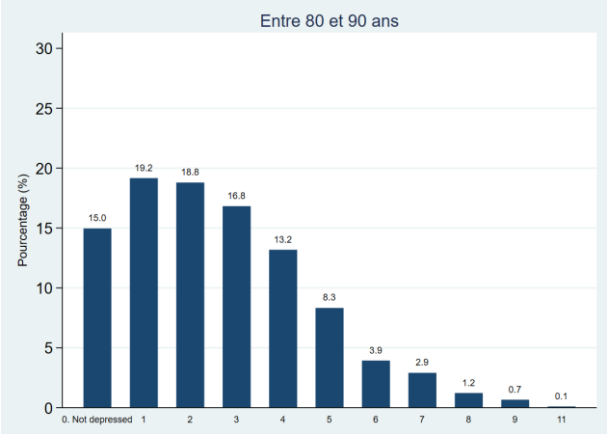


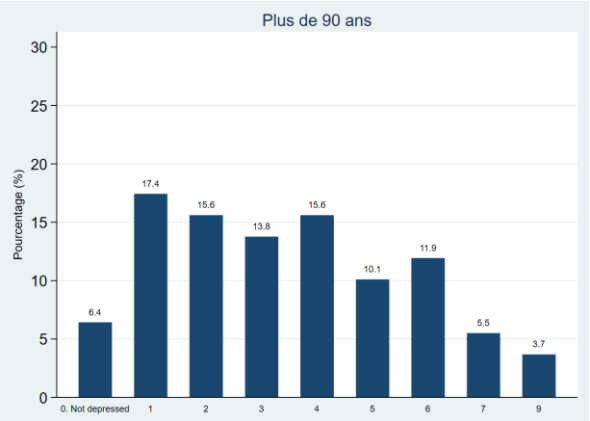
Les deux pays montrent une distribution similaire où les niveaux de dépression décroissent progressivement. La catégorie 1, qui est très peu dépressif, représente la proportion la plus élevée dans les deux cas. Le pic atteint environ 13% en Allemagne contre environ 8% en Suède. L'Allemagne présente des taux de dépression légèrement plus élevés que la Suède. Les niveaux de dépression sévères sont très faibles dans les deux pays, ne dépassant pas 1%.

De manière générale, la majorité des individus dans les deux pays ne présente pas de symptômes dépressifs. Seulement, l'Allemagne semble avoir plus de personnes souffrant de dépression légère et modérée.





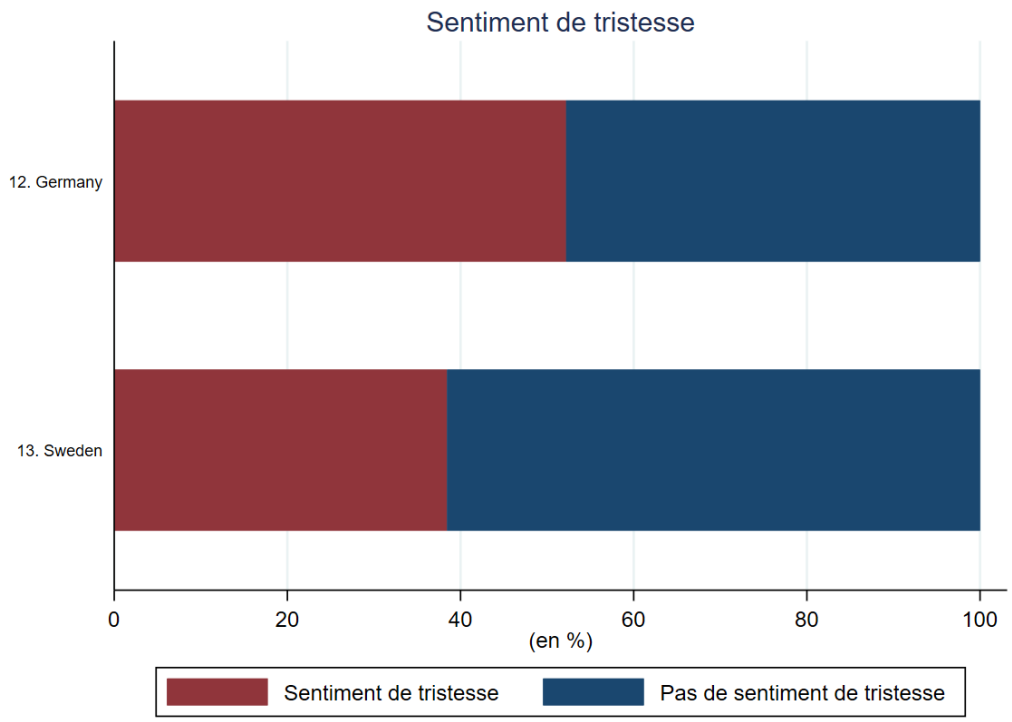




Globalement, nous observons une tendance nette à la baisse de la catégorie 0 « non dépressif ». cela montre que la vieillesse est associée à une augmentation de la dépression. Elle s'intensifie progressivement avec l'âge.

Sentiments de tristesse

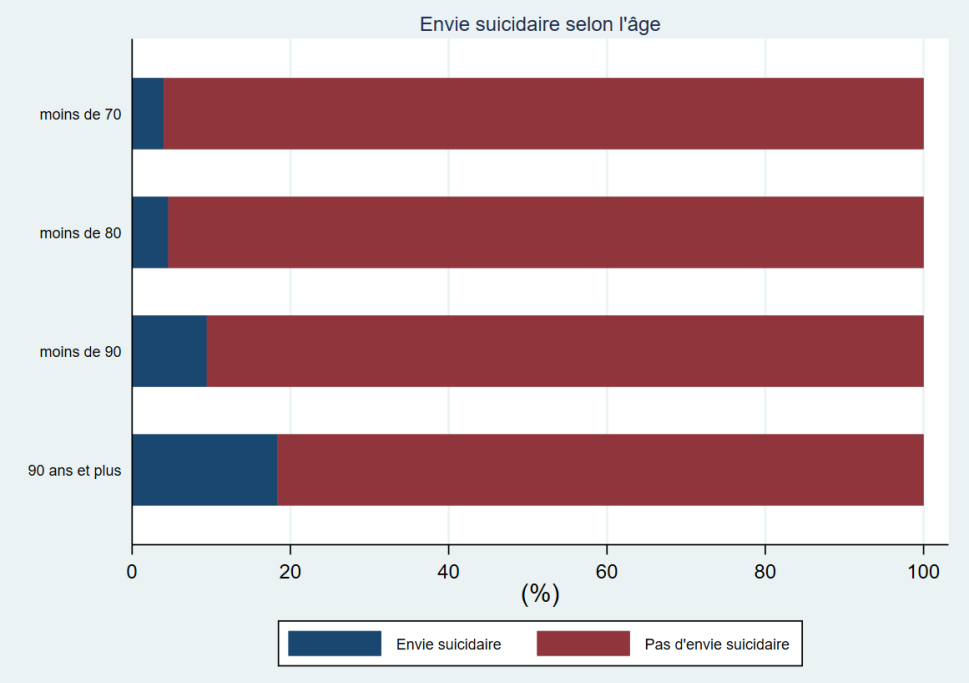
Cette mesure nous indique si le répondant s'est senti triste ou déprimé au cours du dernier mois.



Environ 50% des Allemands ont ressenti de la tristesse au cours du dernier mois et près de 39% des Suédois ont déclaré s'être sentis tristes dans le mois précédent. De ce fait, la Suède indique un pourcentage inférieur de personnes ressentant de la tristesse comparé à l'Allemagne.

Envie suicidaire

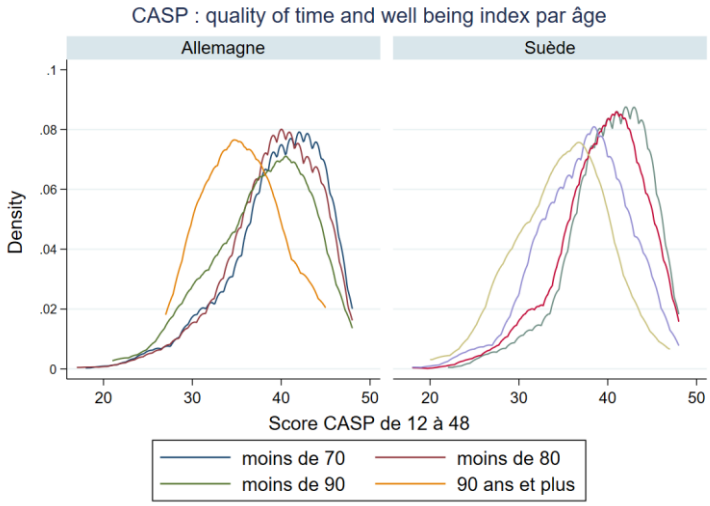
Les répondants ont été intérrogées si au cours du drnier mois, ils ont émis le souhait d'etre mort.



Nous remarquons que l'envie suicidaire augmente progressivement avec l'âge. Pour les moins de 70 ans, en 5% de l'échantillon de moins de 70 ans ont eu des pensées suicidaires. Environ 10% des moins de 90 ont eu des envies suicidaires. Enfin, chez les personnes âgées, près d'une personne sur 5 révèle avoir eu des pensées suicidaires. Ce qui pose un réel problème de santé mentale chez les personnes très âgées. Il faut donc renforcer la prévention du suicide chez les seniors et leur apporter un soutien psychologique.

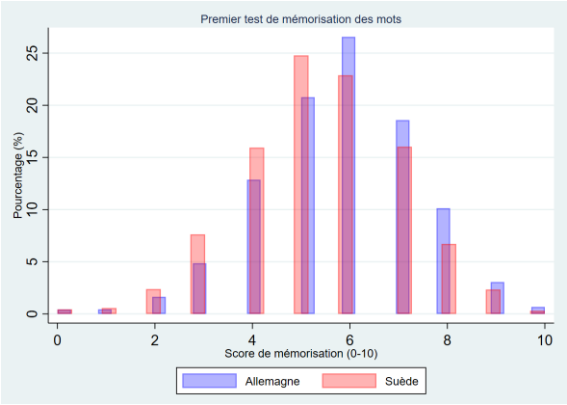
CASP : qualité de vie et de bien être

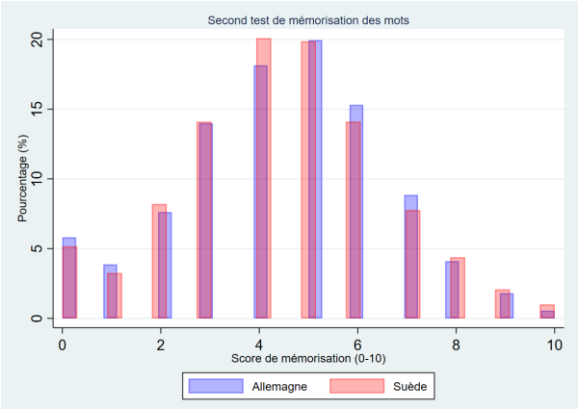
Le score CASP évalue la qualité de vie en combinant 4 dimensions, à savoir le contrôle, l'autonomie, le plaisir et la réalisation de soi. Les valeurs les plus élevées reflètent une meilleure qualité de vie.



En effet, dans les deux pays, la densité des personnes est marquée sur les scores les plus élevés, à l'exception de la tranche des Allemands âgés 90 ans et plus. Les suédois manifestent un score de qualité de vie plus élévé comparé à l'Allemagne, dans toutes les catégories confondues. Par contre, l'âge ne semble pas être associé au score de la qualité de vie et de bien-être.

- Capacité de mémorisation





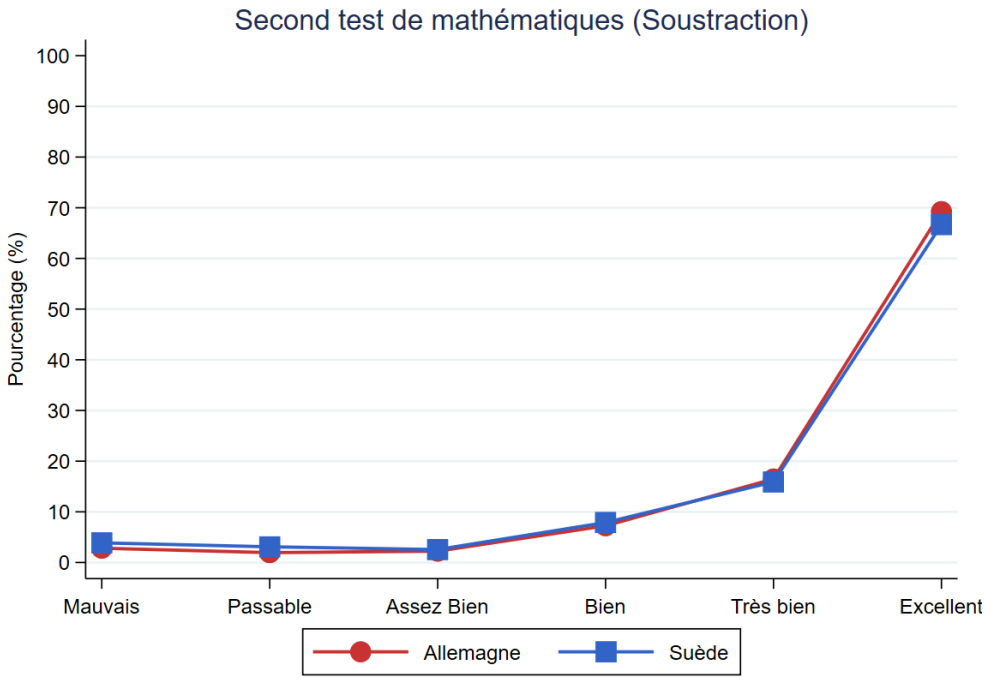
Aux deux tests de mémorisation, plus de 20% dans les deux pays ont réussi à se rappeler 5 mots sur les 10. Au premier test, les suédois sont les plus nombreux aux scores très faibles par rapport aux suédois.

Le second test a été utilisé pour évaluer leur capacité de retenir, puisqu'il fallait que les répondants se rappellent des mots mémorisés au premier test. Sur ce second test, plus de difficultés pour les allemands à se rappeler des mots et sur le reste des scores, même les plus élevés, moins de difficultés à retenir les mots.

Les deux tests montrent des distributions similaires, mais la suède a légèrement plus de scores élevés par rapport à l'Allemagne.

Test de mathématique

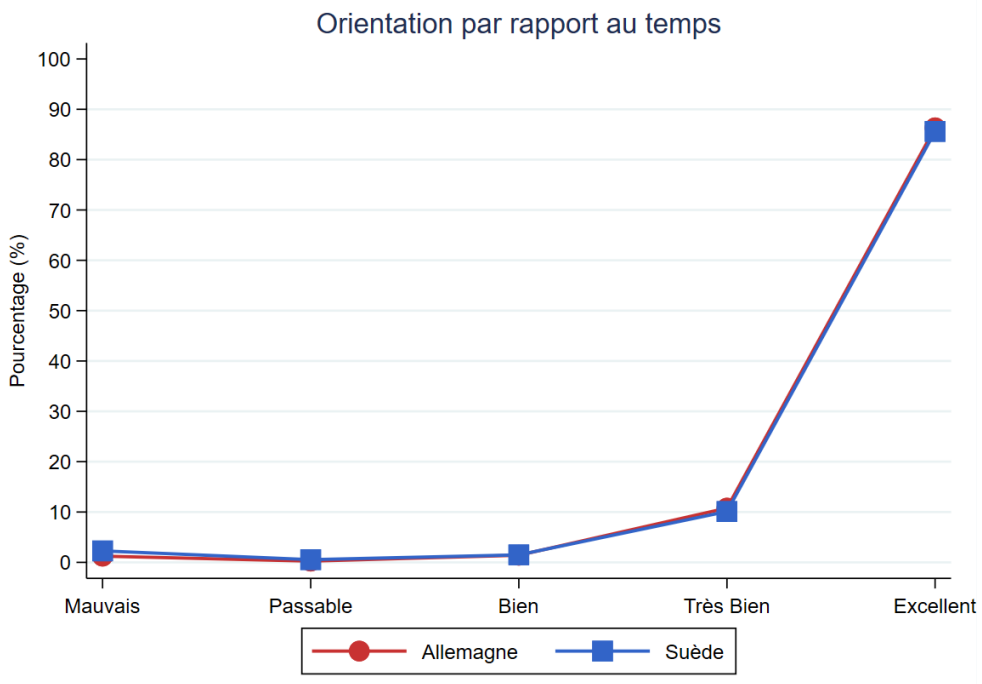
Le premier test de mathématique ; 5 249 répondants n'ont pas répondu à la question, donc ce n'est serait pas très pertinent d'étudier cette variable. En revanche, pour le test de soustraction, presque tous les répondants ont répondu à la question.



La grande majorité des personnes, environ 70%, obtiennent un niveau Excellent au test de soustraction, conduisant à une augmentation exponentielle aux niveaux supérieurs. Le test de soustraction est relativement simple pour la plupart des personnes âgées. Contrairement aux autres tests, il n'y a pas de différence notable entre l'Allemagne et la Suède pour les compétences mathématiques.

Orientation dans le temps

Elle permet de mesurer la capacité de se repérer, par rapport à la date, au mois, à l'année et au jour de la semaine.



Les deux courbes sont pratiquement superposées. Environ 85% des personnes ont un niveau excellent d'orientation temporelle. Tout comme pour le second test de mathématiques, on a une augmentation exponentielle des résultats vers des scores très élevés. Ce qui nous montre qu'après tout, la conscience reste globalement intacte avec l'âge.

Pour faciliter la comparaison directe de ces plusieurs mesures, le tableau ci-dessus présente les moyennes des variables que nous venons d'analyser dans les 2 pays :

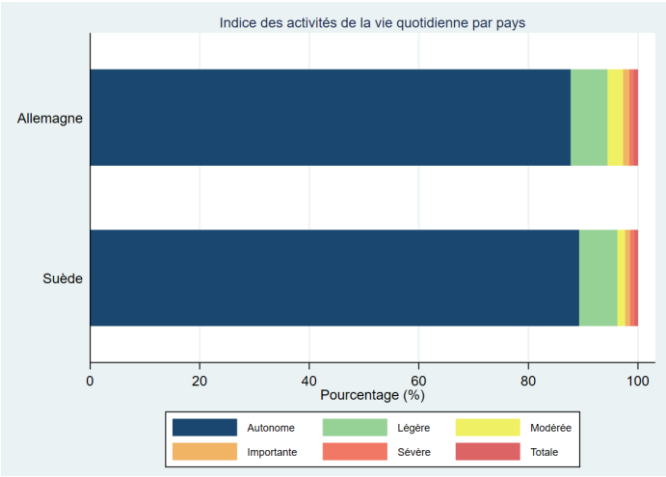
Moyenne	Allemagne	Suède
Eurod (sur 12)	2,48	2,23
CASP (sur 48)	39,08	39,16
Recall1 (sur 10)	5,80	5,45
Recall2 (sur 10)	4,417	4,443
Numeracy2 (sur 5)	4,40	4,28
Orienti (sur 4)	3,80	3,76

III. Dépendance

En vieillissant, les personnes âgées se retrouvent souvent face à des problèmes de santé qui compliquent leur quotidien et réduisent peu à peu leur autonomie[7]. Cette perte d'autonomie rend indispensable le recours à une aide, qu'elle vienne de la famille ou des aides professionnels. La dépendance ne tient donc pas seulement à un état de santé, mais elle est aussi liée à l'entourage et au soutien dont on dispose. Quand un conjoint ou des enfants sont présents à l'intérieur du ménage ou à proximité de la maison, ils peuvent atténuer les difficultés quotidiennes et limiter le recours à une aide extérieure, qui est souvent très couteuse. Cette dimension permettra d'éclairer le degré de dépendance des personnes âgées dans les deux pays.

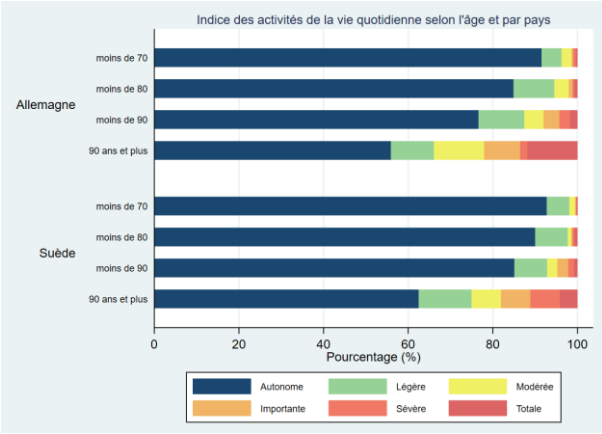
Indice des activités de la vie quotidienne

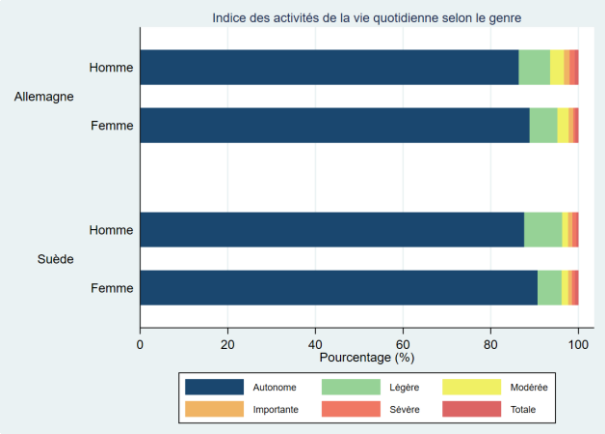
Dans la même logique de comparaison entre les deux pays, nous examinerons, pour chacun d'eux, les répondes des individus aux questions liées aux capacités de s'habiller, de se laver, manger, traverser une pièce, etc.



Environ 90% des personnes maintiennent leur autonomie dans les activités quotidiennes. Une petite portion a des difficultés légères, plus en Suède, mais cette difficulté reste minime et leur laisse encore vivre de manière indépendante.

[7] Bonnet, Carole., et al. « Dynamiques, enjeux démographiques et socioéconomiques du vieillissement dans les pays à longévité élevée ». Population, 2021/2 Vol. 76, 2021. p.225-325.





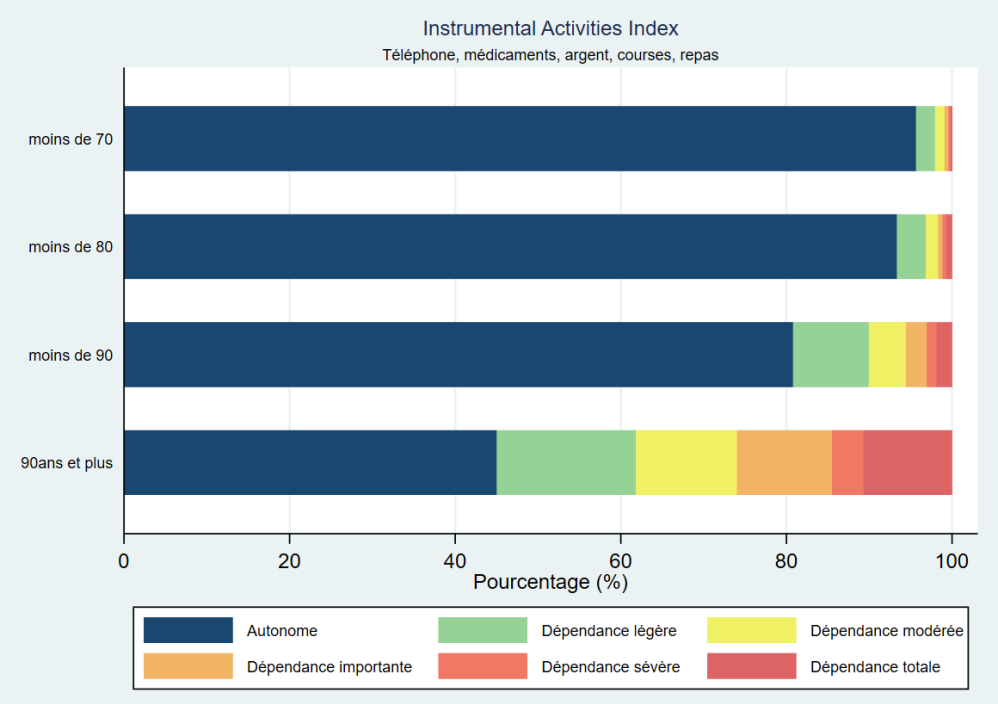
En visualisant ces graphiques, nous pouvons voir que la perte d'autonomie s'accélère particulièrement chez les personnes de 90 ans et plus, surtout chez les allemands.

Les distributions sont pratiquement identiques en Allemagne et en Suède. Les répondants ont gardé leur autonomie de façon un peu similaire, mais les suédois apparaissent légèrement plus autonomes. Le premier graphique nous montre également que l'âge compte dans la réduction de l'autonomie chez les personnes âgées, probablement à cause d'une accumulation de maladies chroniques, d'incapacité physique, etc.

Dans les deux pays, les femmes sont plus autonomes que les hommes, même si, généralement, les deux genres possèdent une autonomie aux environs de 90%.

- Indice des activités instrumentales

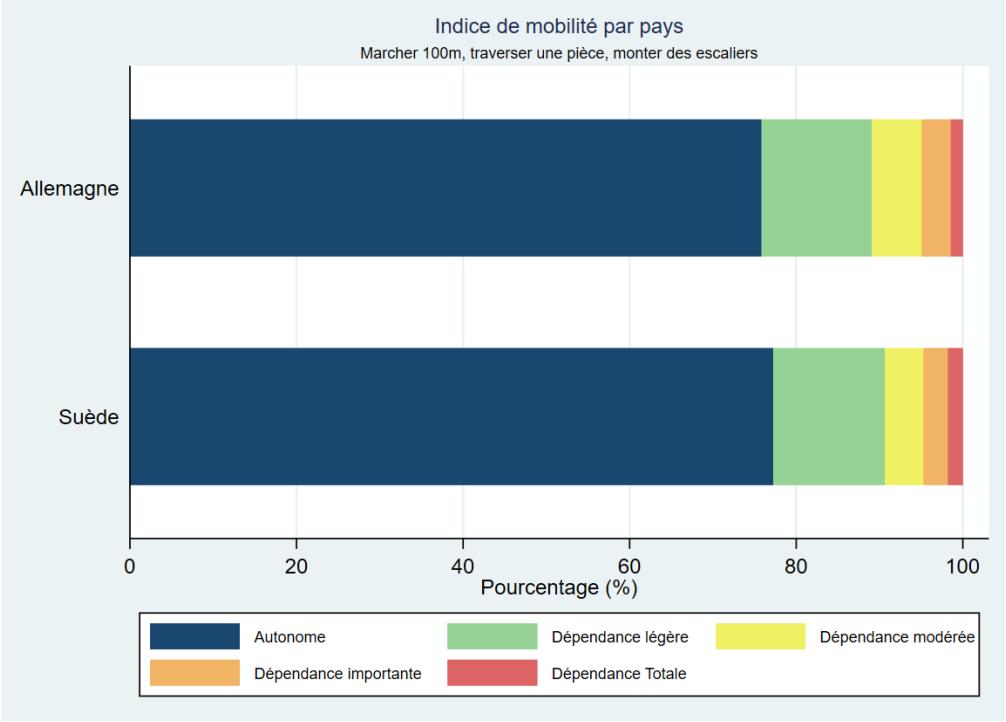
Il correspond à la somme des difficultés liées aux appels téléphoniques, à la prise de médicaments, à la gestion de l'argent, aux courses alimentaires et à la préparation des repas. Plus la valeur de l'indice est élevée, plus les capacités fonctionnelles du répondant est réduite.



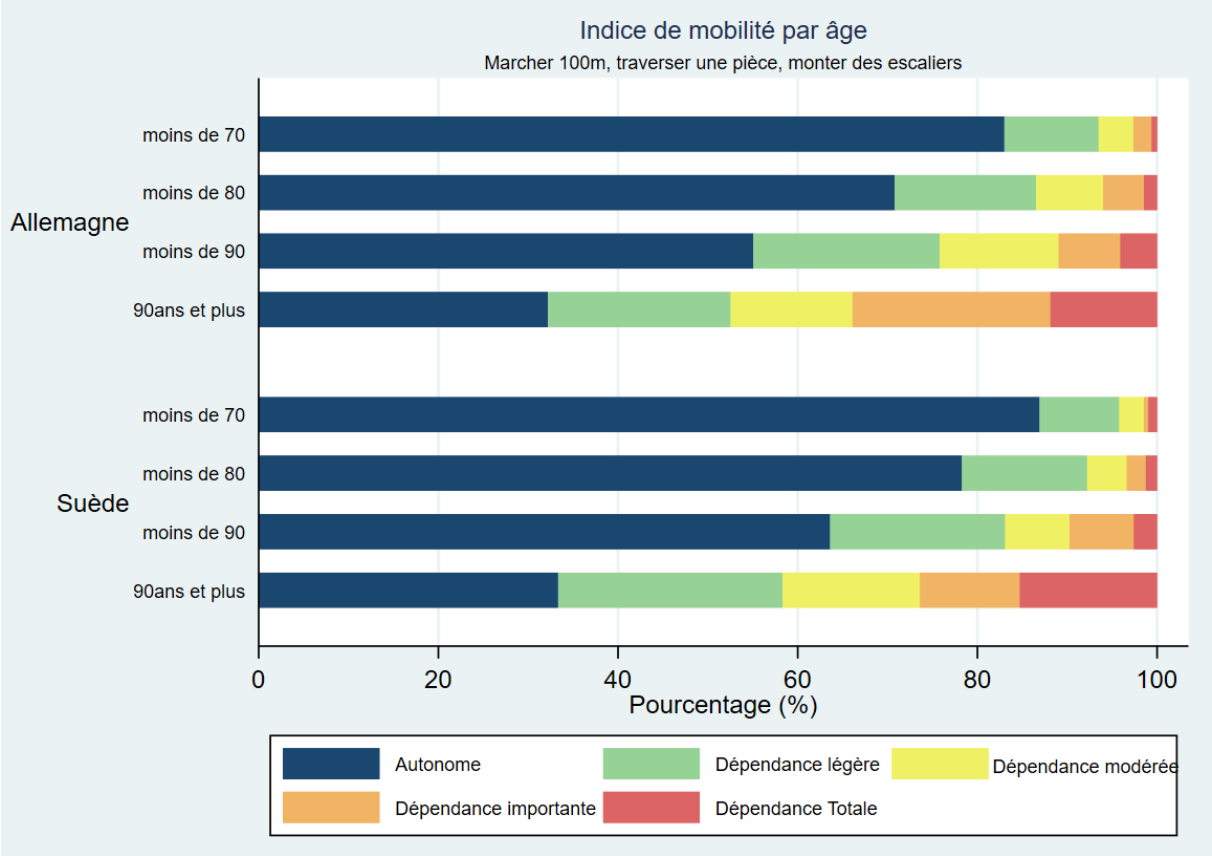
Comme l'indice des activités à la vie quotidienne, cet indice est aussi lié à la tanche d'âge. Le déclin est encore plus prononcé après 90 ans. Ce qui signifie qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, une certaine autonomie liée au passage des appels téléphoniques, à la prise des médicaments, au gestion d'argent, etc, est perdue progressivement.

Indice de mobilité

Il représente la capacité des répondants à faire des marches de 100 mètres, à monter des escaliers, aller d'une pièce à une autre, etc.



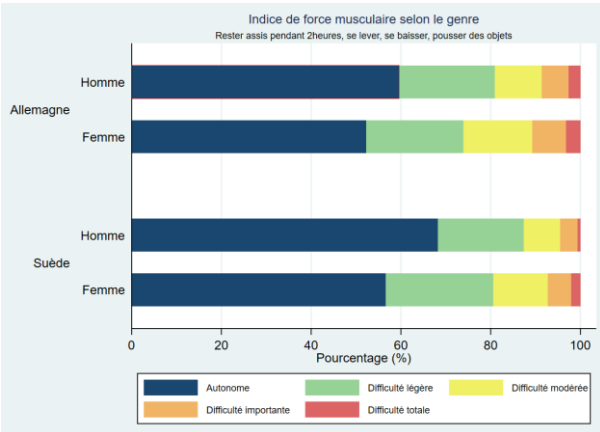
L'Allemagne et la Suède présentent des distributions presque similaires quant à cet indice. Cette visualisation nous montre que presque 80% des personnes âgées de 60 ans et plus de l'échantillon affichent une indépendance totale. Environ 15% des répondants ont une dépendance modérée, cela explique que certains répondants n'arrivent pas à réaliser certaines tâches quotidiennes.

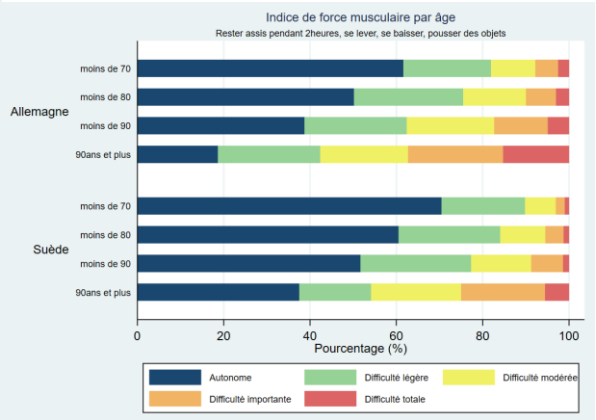


L'âge reste un facteur qui est associé à plusieurs pertes d'autonomie, l'indice de mobilité ne fait pas exception. Plus de 80% des répondants de moins de 60 ans ont une autonomie totale contre plus de 15% de répondants de 90 ans et plus qui souffrent de dépendance totale liée à la mobilité.

Indice de force musculaire

Il mesure les limitations fonctionnelles liées aux grands muscles, comme rester assis longtemps, se lever d'une chaise, se pencher ou pousser des objets. Plus l'indice est élevé, plus la personne rencontre de difficultés liées à la force musculaire.



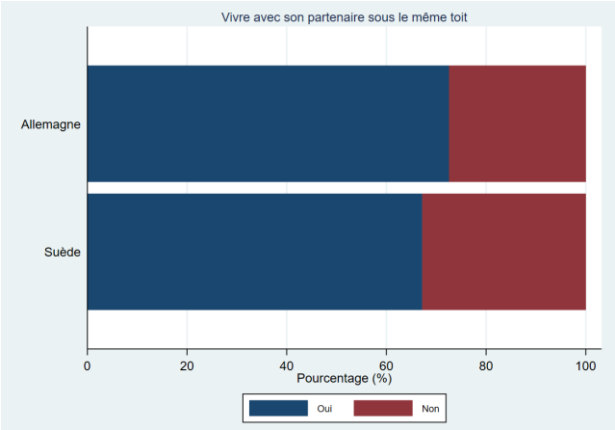


Les hommes ont une force musculaire plus élevée par rapport aux femmes, que ça soit en Allemagne ou en Suède. Les Suédois ont une force musculaire plus prononcée que les Allemands. Les femmes semblent avoir des difficultés importantes par rapport aux hommes.

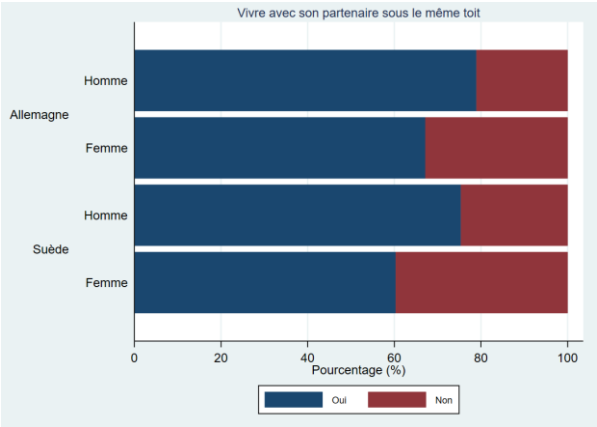
Les répondants très âgés montrent un ensemble de difficultés. Dans les deux pays, ce sont eux, les plus de 90 ans, qui représentent la proportion la plus élevée de la difficulté totale. Ensuite, l'âge semble être un facteur déterminant pour la perte des capacités musculaires.

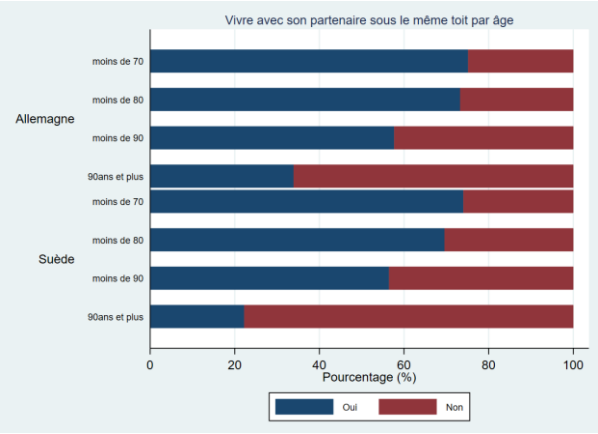
Vivre avec son partenaire sous le même toit que le répondant

Cet indicateur nous permet de voir si les répondants bénéficient d'une aide intérieure du foyer.



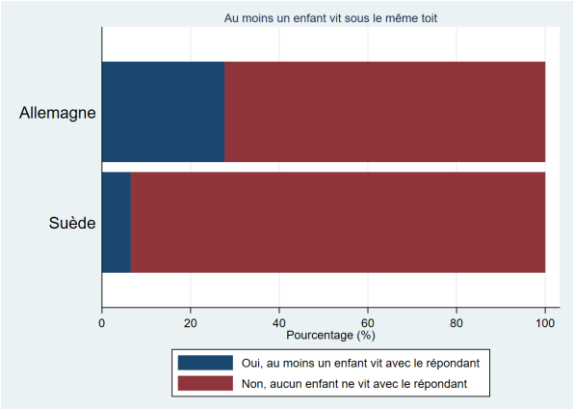
Les Allemands vivent plus avec leur partenaire que les Suédois, malgré que pour les deux pays, la proportion des répondants qui vivent avec leur partenaire oscille entre 65-70 %. Cela sous-entend que les deux pays, mais plus l'Allemagne, peuvent profiter de l'aide de l'autre au quotidien.

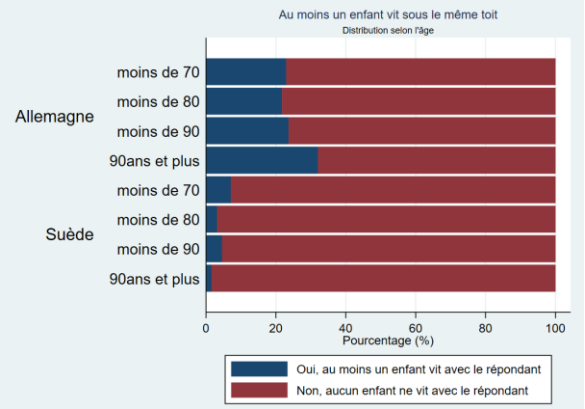




Les hommes vivent plus avec leurs partenaires que les femmes. Nous constatons une part plus importante des répondants aux alentours de 80%, dans les deux pays, qui vivent avec leurs partenaires chez les jeunes seniors. L'age fait que son avancement diminue la proportion de vivre avec son partenaire dans la même maison, surément à cause des décès des conjoints ou juste à cause des ruptures.

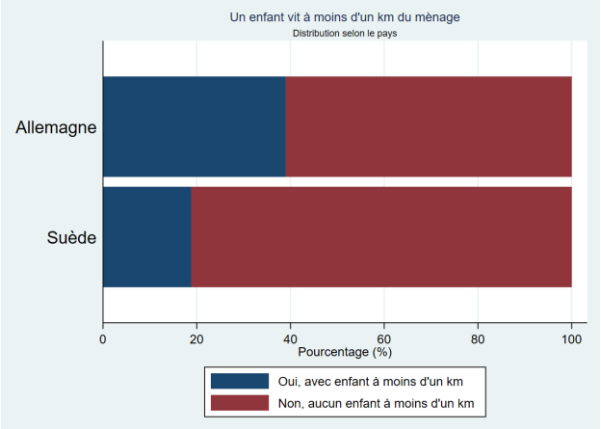
Au moins un enfant vit dans la même maison que le répondant

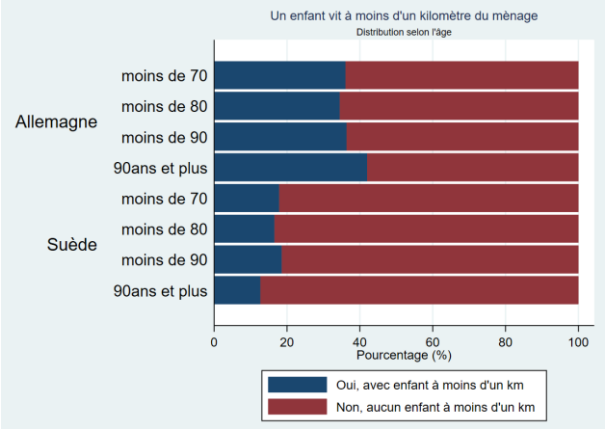




En Allemagne, la proportion des répondants qui ont au moins un enfant vivant sous le même toit est d'environ 25%, contre environ 5% en Suède. Cela se reflète aussi sur la distribution selon l'âge, peu importe l'âge, la proportion allemande l'emporte et une proportion plus élevée chez les générations de plus de 90 ans, en Allemagne, ce qui n'est pas du tout le cas de la Suède. Nous pouvons faire, dans ce cas, un lien avec la perte d'autonomie ; les enfants doivent s'occuper de leurs parents.

Proximité géographique avec le(s) enfant (s)

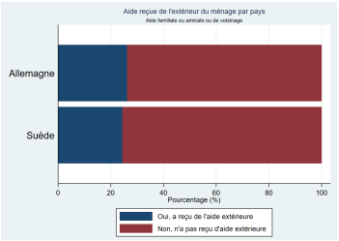


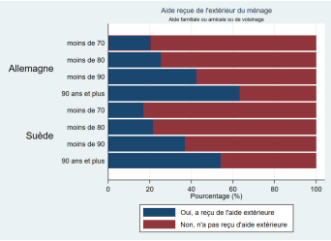


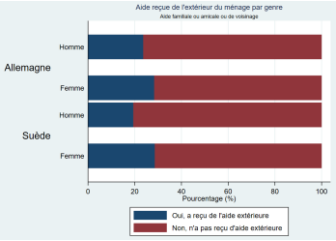
Ici, la proportion des répondants qui ont au moins un enfant vivant à moins d'un kilomètre est d'environ 40%, contre environ 20% en Suède. La distribution selon l'âge a une ressemblance presque parfaite avec la distribution selon l'âge de la variable concernant les enfants vivant sous le même toit que le répondant.

Les 90 ans et plus habitent plus à proximité de leurs enfants que les moins de 80 ans. Et c'est le même cas qui est observé en Suède mais avec des proportions différentes.

Aide reçue de l'extérieure du ménage





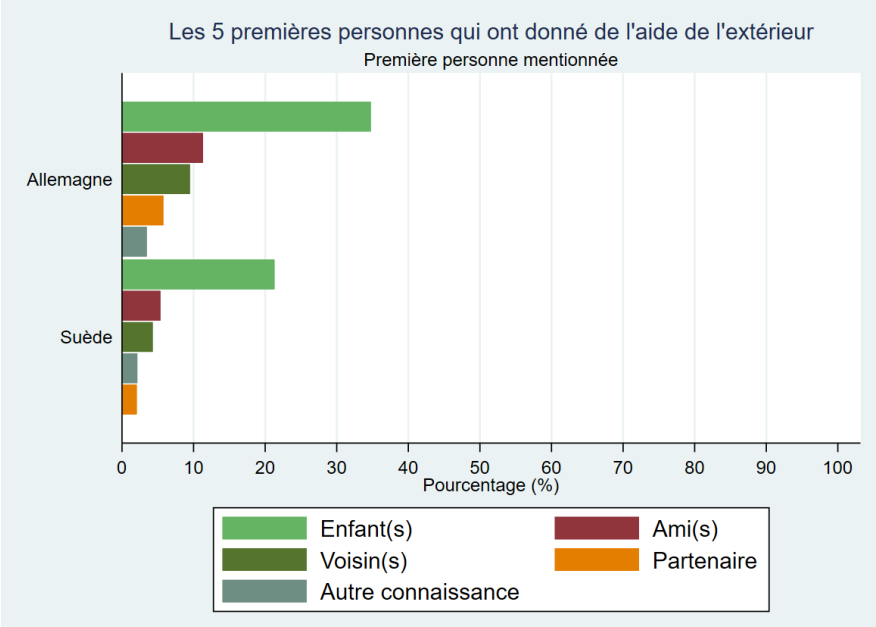


Les deux pays reçoivent à peu près la même proportion d'aide extérieure. Par contre, des différences se font ressentir dans les distributions selon l'âge et le genre. Plus de 60% des répondants âgés de 90 ans et plus reçoivent de l'aide venant de l'extérieure, suivi par les moins de 90 ans, avec environ 50% de répondants.

Environ 30% des femmes, qu'elles soient allemandes ou suédoises, reçoivent de l'aide provenant de l'extérieure. La proportion des hommes allemands est plus grande comparée à celle des hommes suédois. Mais la majorité ne reçoit pas d'aide dans les deux pays.

Les cinq premières personnes offrant leur aide aux répondants

Les répondants ont eu à répondre à la question de qui ils recevaient de l'aide extérieure.



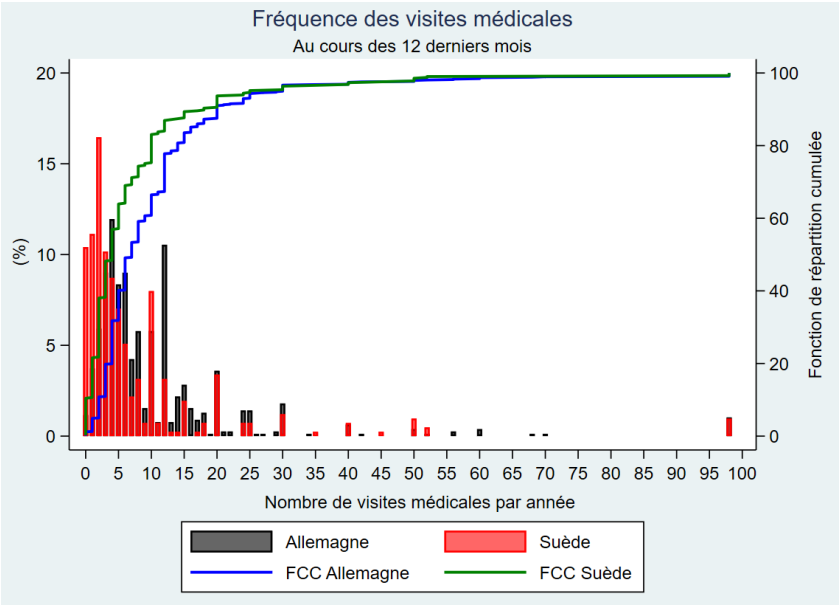
Sur les cinq premières personnes mentionnées par les répondants comme donnant de l'aide de l'extérieur, la première position revient aux enfants, qui constituent la principale source de soutien extérieur avec 30% en Allemagne et 20% en Suède, loin devant les amis, les voisins, les partenaires et enfin, les autres connaissances. Nous remarquons encore une fois une proximité familiale plus marquée en Allemagne qu'en Suède.

IV. Accès aux soins

La question d'accès aux soins vaut surtout pour les personnes âgées parce que nous savons que les besoins et les dépenses de santé augmentent très fortement en fonction de l'âge. Le désert médical est plus prononcé en milieu rural, avec seulement 32% de personnes âgées en zone rurale se déclarant autonomes contre 51,5% en zone urbaine[8].

- A quelle fréquence avez-vous vu ou parlé à un médecin au cours des 12 derniers mois ?

[8] Bontron, Jean-Claude. « L'accès aux soins des personnes âgées en milieu rural : problématiques et expériences ». Gérontologie et société, 2013/3 vol. 36 / n° 146, 2013. p.153-171.



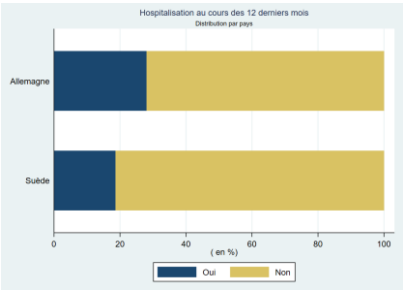
Ce graphique nous montre la distribution du nombre de visites médicales réalisées au cours des 12 derniers mois par les personnes âgées entre 60 ans et plus. Nous avons deux représentations à la fois. Premièrement, nous avons des histogrammes montrant la fréquence pour chaque nombre de visites et ensuite, nous avons des courbes de répartition cumulée pour observer la distribution globale.

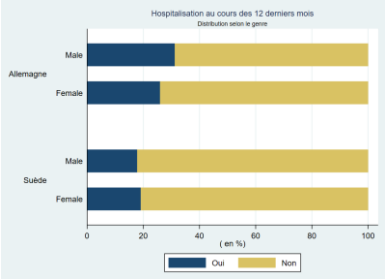
Les résultats nous révèlent que les Allemands consultent plus fréquemment que les suédois. La distribution allemande montre une dispersion plus importante et des valeurs extrêmes plus élevées, avec des individus déclarant des nombres très élevés de visites médicales.

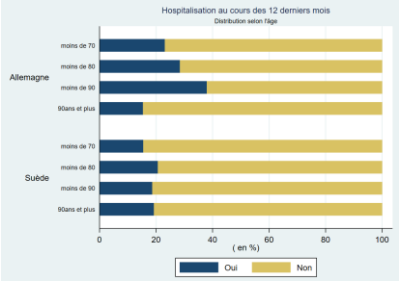
Cette tendance se confirme avec la fonction de répartition cumulée. Pour un même nombre de consultations, la proportion cumulée est plus élevée en Suède qu'en Allemagne, ce qui indique que les Suédois atteignent plus rapidement les niveaux faibles de consultations.

La courbe allemande augmente plus lentement, ce qui signifie que les Allemands consultent en moyenne plus souvent un médecin.

- Hospitalisations lors des 12 derniers mois par pays et selon l'âge



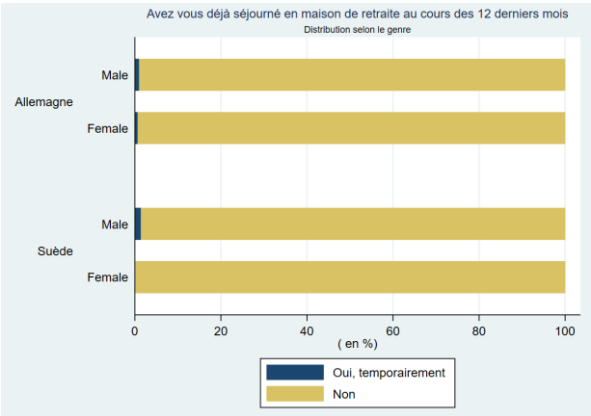


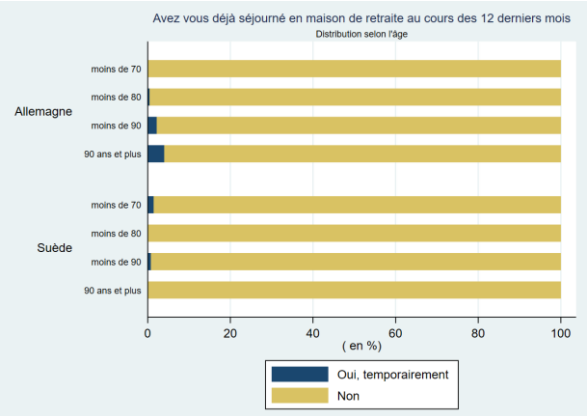


Nous pouvons le constater encore une fois sur ces distributions. Les Allemands sont ceux qui ont été le plus hospitalisés au cours des 12 derniers mois. Ils représentent environs 30% de la population allemande de notre échantillon, contre 19% de suédois de la population suédoise. Peu importe le genre, les Allemands prédominent en ce qui concerne les hospitalisations l'année dernière.

Ensuite, Les répondants allemands ayant un âge compris entre 80 et 90 ans sont ceux qui ont été le plus hospitalisé, en Allemagne, l'année précédente. En Suède, c'est le groupe d'âge de 70-80 ans, toutefois, l'Allemagne reste le pays avec des plus fortes portions d'hospitalisations sur presque toutes les catégories d'âge, à l'exception de la catégorie suédoise de 90 ans et plus.

- Les nuitées en maison de retraite au cours des 12 derniers mois





Ici, les hommes sont ceux qui ont le plus temporairement séjourné dans des maisons de retraites, dans les deux pays. Malgré que 99% des répondants déclarent ne pas avoir séjourné dans des maisons de retraites, les personnes ayant un âge de 90 ans et plus affichent des proportions élevées comparé aux autres catégories d'âge, en Allemagne.

Nous avons également utilisé les données issues de la banque mondiale portant sur la disponibilité des infrastructures et du personnel de santé, notamment le nombre de lits d'hôpitaux, d'infirmiers et de sages-femmes ainsi que les chirurgiens spécialisés, par rapport à la population.

	Allemagne	Suède
Nombre de lits d'hopitaux	7,8 pour 1000 personnes (2020)	2.0 pour 1000 personnes (2020)

Infirmiers et sage-femmes	12,3 pour 1000 personnes (2021)	11,4 pour 1000 personnes (2020)
Chirurgiens spécialisés	108 pour 100 000 personnes (2015)	113 pour 100 000 personnes (2015)

D'après ce tableau, l'Allemagne dispose de beaucoup plus de places dans les hôpitaux qu'en Suède, ce qui facilite en quelque sorte l'accès aux soins et la prise en charge des patients. Il compte également un peu plus de personnels, avec les infirmiers et les sages-femmes, ce qui peut améliorer la qualité et éviter des soins tardifs. Par ailleurs, la Suède a un peu plus de spécialistes chirurgiens disponibles pour les soins complexes, même si cette différence n'est pas énorme. En conclusion, nous pouvons dire que l'Allemagne offre un meilleur accès aux soins que la Suède.

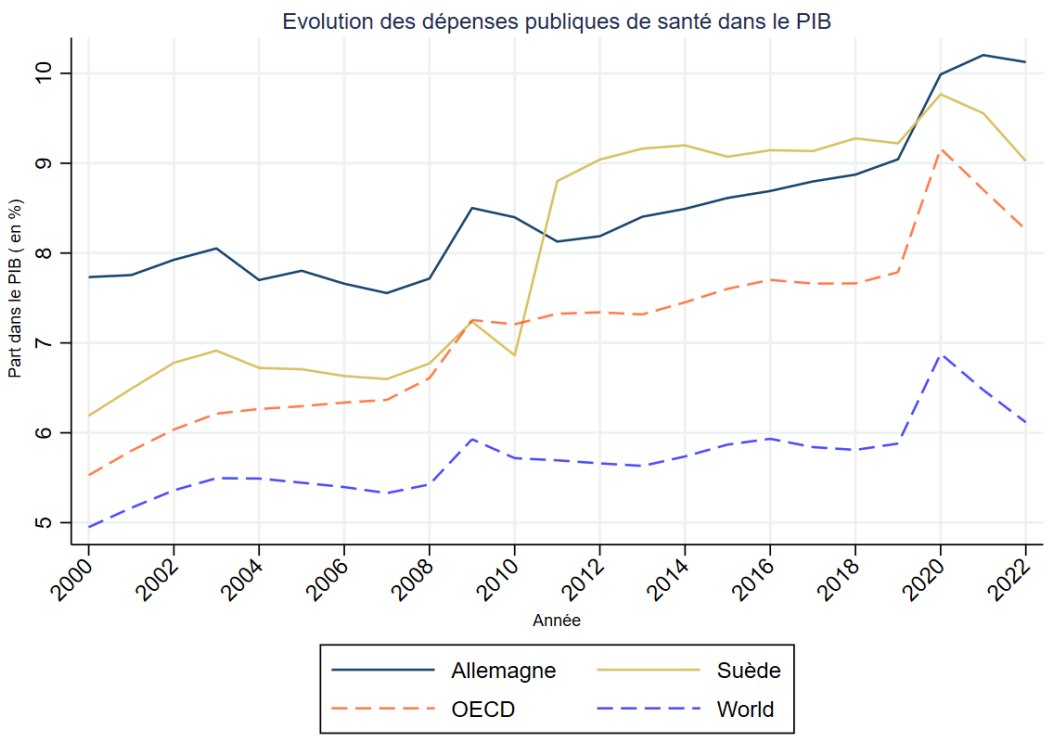
V. Dépenses de santé

Afin de comparer les dépenses de santé de l'Allemagne et de la Suède, Nous allons axer notre analyse sur les différents points essentiels, notamment les dépenses publiques de santé, la part des dépenses de santé dans le budget national, et les dépenses moyennes de santé par personne. Ces indicateurs vont nous permettre de comprendre comment chaque gouvernement finance son système de santé. Nous nous baserons sur les données de la banque mondiale.

Dépenses du gouvernement

- Dépenses publiques de santé dans le Produit Intérieur Brut (PIB)

La représentation ci-dessous montre comment les dépenses publiques ont évolué entre 2000 et 2022.

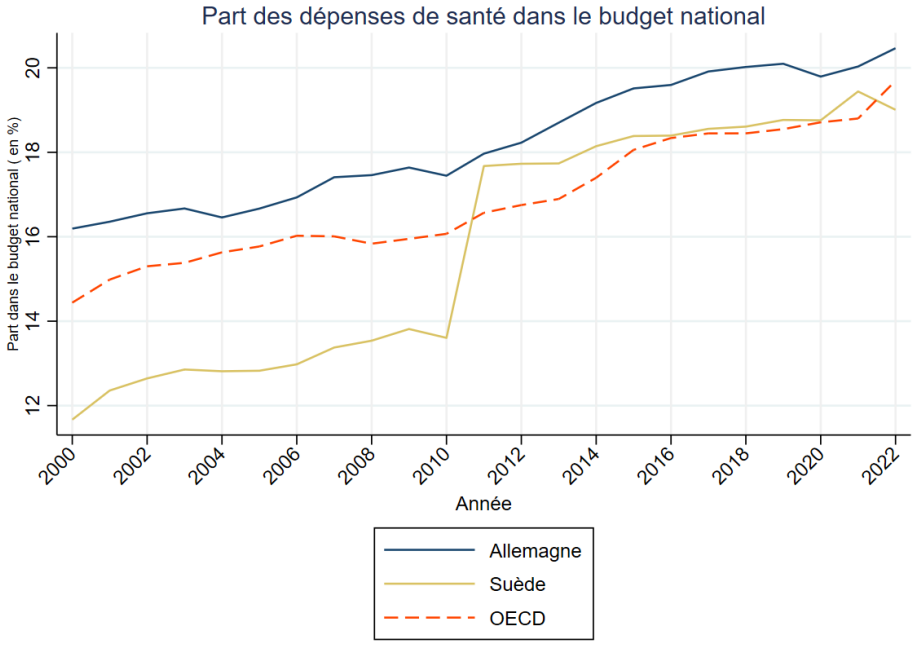


Tout d'abord, l'Allemagne a connu une augmentation progressive de la part de ses dépenses de santé dans le PIB. Celle-ci est passée de 7,8% en 2000 à 10,1% en 2022, soit une hausse d'environ 3 points de pourcentage.

Quant à la Suède, La part des dépenses de santé a également augmenté. Elles sont passées de 6,2% en 2000 à 9% en 2020.

Ainsi, dans les deux pays, La part des dépenses en santé dans le PIB a augmenté au fil des années. Cependant, l'Allemagne consacre une part relativement plus importante de son budget national à la santé que la Suède. De plus, les deux courbes se situent au-dessus de la moyenne de l'OCDE et de la moyenne mondiale, ce qui montre que ces deux pays investissent davantage dans leur système de santé. Enfin, nous ne pouvons pas négliger le pic important des dépenses de santé, en Suède, dans les années 2010, liées en grande partie aux progrès médicaux, ce qui a entrainé une hausse globale des dépenses de santé.

Part du budget national

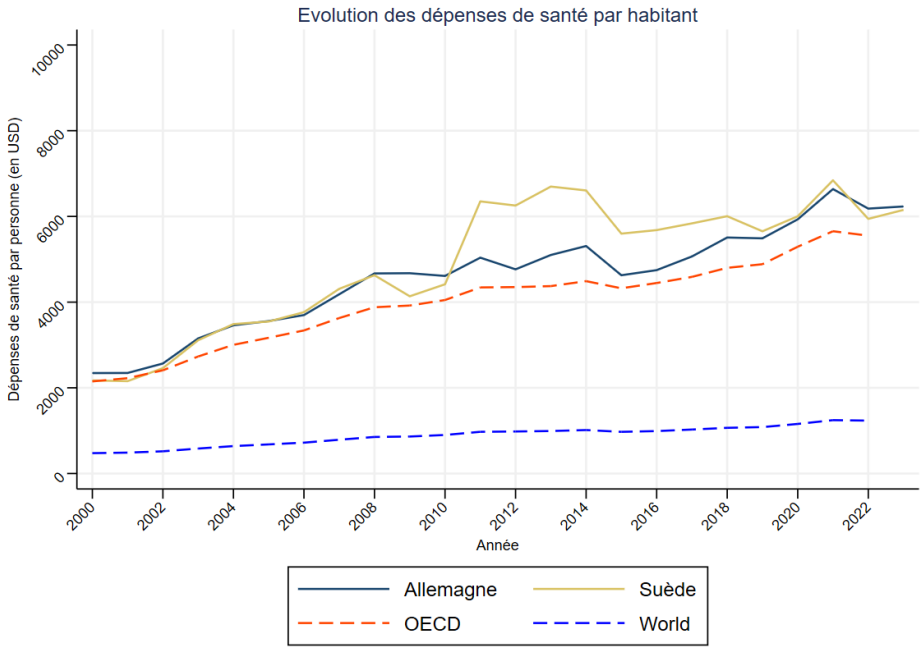


Dans cette partie, on observe également que la part des dépenses de santé dans le budget national est plus élevée en Allemagne qu'en Suède. En effet, en 2020, les dépenses de santé représentent environ 21% du budget national en Allemagne, contre environ 19% en Suède.

L'Allemagne dépasse ainsi, une nouvelle fois, la moyenne des pays de l'OCDE, ce qui montre qu'elle consacre une part importante de ses ressources publiques au financement de la santé.

En Suède, en revanche, la part des dépenses de santé est inférieure à la moyenne de l'OCDE, cela peut indiquer dans un sens, une meilleure gestion des ressources publiques.

Dépenses de santé par habitant



En revanche, les dépenses personnelles de santé restent en Allemagne, proches, et similaires aux tendances observées en Suède.

Malgré certaines fluctuations et une évolution progressive des dépenses de santé par habitant, que ce soit en Allemagne, en suède, dans les pays de l'OCDE, les niveaux restent globalement stables à l'échelle mondiale sur la période étudiée.

Sur la période de 2000 et 2023, Les courbes de l'Allemagne et de la Suède se confondent parfaitement, ce qui montre une évolution identique des dépenses de santé par habitant dans ces deux pays.

En 2020, un habitant allemand comme un habitant suédois dépensait en moyenne 6000 dollar par an pour sa santé. Cela montre que, malgré des systèmes de santé différents, les dépenses de santé par personne sont similaires et bien maitrisées dans les deux pays.

VI. Conclusion

En résumé, cette étude de comparaison entre l'Allemagne et la Suède montre que le vieillissement concerne les deux pays de manière similaire, mais met en lumière aussi des différences marquées dans l'état de santé et la prise en charge des personnes âgées.

Sur le plan de la santé physique, les personnes âgées suédoises déclarent globalement un meilleur état de santé perçu que les Allemands, ces derniers étant davantage concentrés dans des états de santé jugés médiocres par rapport à la proportion suédoise, dans cette même catégorie.
Dans les deux pays, le vieillissement s'accompagne d'une dégradation progressive de la santé, mais la vulnérabilité physique apparaît plus précoce en Allemagne, tandis qu'en Suède, elle touche surtout les âges très avancés. Les comportements à risque, comme le tabagisme, restent plus fréquents en Allemagne, ce qui peut contribuer à ces écarts.

Concernant la santé mentale, les niveaux de dépression, de tristesse et les scores de qualité de vie et de bien-être sont plus défavorables en Allemagne, alors que la Suède présente des résultats globalement plus protecteurs. Toutefois, dans les deux pays, l'âge avancé reste fragilise la santé mentale. Plus les personnes sont âgées, plus les signes de dépression et les pensées suicidaires augmentent, surtout chez les plus de 90 ans.

La dépendance reste faible, puisque la plupart des personnes âgées conservent leur autonomie. Cependant, avec l'âge, certaines activités du quotidien deviennent plus difficiles. L'Allemagne se distingue par une forte proximité familiale, qui apporte un soutien important aux personnes âgées et limite le recours à des aides professionnelles. En Suède, cela fait que l'aide extérieure est plus souvent nécessaire.

Par rapport à l'accès aux soins, les personnes âgées allemandes consultent plus souvent les médecins et sont plus fréquemment hospitalisées que les Suédois. Cela montre une prise en charge plus médicale du vieillissement en Allemagne.

Enfin, les dépenses de santé sont élevées dans les deux pays si on les compare avec la moyenne des pays de l'OCDE. Mais l'Allemagne affiche un investissement public légèrement plus important par rapport à la Suède, même si les dépenses par habitant restent proches et augmentent de manière régulière.

Sur le plan empirique, cette étude gagnerait à être approfondie par des analyses économétriques afin de mieux identifier les relations causales entre l'âge avec la santé physique et mentale, la dépendance avec l'âge ou non, etc, bien que juste avec un regard extérieur, cette cause à effet semble être indéniable. Cela

permettrait de mieux renseigner les décideurs publics et de cibler plus précisément les actions et les politiques là où le besoin est le plus important.

Pour conclure, cette comparaison montre que le vieillissement est un défi commun, mais que la manière dont il est géré varie selon les pays. La prévention des pertes d'autonomie doit devenir une priorité, en agissant tôt pour éviter les limitations fonctionnelles sévères. Le développement des aides techniques, l'adaptation des logements et un meilleur accompagnement médical et psychologique sont essentiels. Car préserver l'autonomie des personnes âgées, c'est améliorer leur qualité de vie et réduire les coûts humains, sociaux et économiques pour nos sociétés vieillissantes.

VII. Bibliographie

- Bontron, Jean-Claude. « L'accès aux soins des personnes âgées en milieu rural : problématiques et expériences ». Gérontologie et société, 2013/3 vol. 36 / n° 146, 2013. p.153-171.

- Cambois, Emmanuelle., et al. « Femmes et hommes ne sont pas égaux face au handicap ». Gérontologie et société, 2004/3 vol. 27 / n° 110, 2004. p.283-291.

- Koutsogeorgopoulou, V. et H. Morgavi (2025), « Vieillissement des populations, ses implications fiscales et les réponses politiques », Documents de travail du Département des affaires économiques de l'OCDE , n° 1844, Éditions OCDE, Paris.

- Mélanie Lepori, « La vulnérabilité physique perçue par les personnes âgées, une comparaison européenne », Populations vulnérables, 3 | 2017, 97-133.

- Meynet, Stéphanie., et al. « Promouvoir la santé mentale des personnes âgées avec des incapacités physiques : revue systématique des interventions proposées à domicile et en établissement ». Recherche en soins infirmiers, 2022/4 N° 151, 2022. p.18-29.

- Population par âge – Tableaux de l'économie française | Insee